

精神病学_题库_242题_v3

精神病学 题库

v3 FINAL | Prompt修正版(防过度加长) | 242题 | 2026-06-21

M1 绪论

A1型题

1. [batch007_M1_A1_001] 精神病学的核心任务是研究精神障碍的：

- A. 病因、诊断、治疗与预防 ☒
- B. 脑结构与功能的异常变化
- C. 心理健康维护的各项活动
- D. 心理学与社会学的交叉理论
- E. 精神疾病患者的司法鉴定

答案：A | 理解 | P1

解析：精神病学是研究精神障碍的医学分科，核心任务为诊断、治疗和预防精神疾病。B属于神经科学，C对应精神卫生，E为司法精神病学（亚专科）。

2. [batch007_M1_A1_002] 精神卫生的概念侧重于：

- A. 诊断和治疗各类精神障碍
- B. 维护和促进心理健康的各项活动 ☒
- C. 运用司法手段管理精神障碍患者
- D. 对精神障碍患者进行康复训练
- E. 研究异常精神活动的外在表现

答案：B | 记忆 | P1

解析：精神卫生侧重维护和促进心理健康，属公共卫生范畴。A为精神病学定义，E为精神症状学。

3. [batch007_M1_A1_003] 精神医学作为广义概念，其涵盖范围包括：

- A. 仅精神病学的诊断与治疗
- B. 精神病学与精神卫生两个领域 ☒

- C. 仅精神卫生的预防与保健
- D. 神经科学与精神药理学
- E. 心理学与社会学全部范畴

答案：B | 记忆 | P1-P3

解析：精神医学是广义概念，涵盖精神病学（临床学科）+精神卫生（公共卫生）两个领域。

4. [batch007_M1_A1_004] 精神障碍的定义涉及以下哪些方面的临床意义紊乱：

- A. 仅认知功能方面
- B. 仅情绪和情感方面
- C. 认知、情绪、行为等方面 ☒
- D. 仅行为和社会功能方面
- E. 神经系统器质性病变

答案：C | 记忆 | P1

解析：精神障碍指认知、情绪、行为等方面出现临床意义的紊乱。E属于神经病学范畴。

5. [batch007_M1_A1_005] 精神障碍病因学中目前公认的综合模型是：

- A. 单纯的生物学遗传因素模型
- B. 单纯的心理社会应激模型
- C. 生物-心理-社会综合模型 ☒
- D. 神经递质失衡单一因素模型
- E. 早期童年创伤决定性模型

答案：C | 理解 | P5-P9

解析：精神障碍病因采用生物-心理-社会综合模型，强调生物学、心理学和社会因素三者的交互作用。

A2型题

6. [batch007_M1_A2_001] 一名医学生想了解精神障碍在人群中的分布规律及影响因素，应学习精神医学的哪个领域：

- A. 临床精神病学
- B. 精神卫生流行病学 ☒
- C. 生物精神病学

- D. 司法精神病学
- E. 心身医学

答案：B | 应用 | P1-P3

解析：研究精神障碍在人群中分布规律及影响因素属于精神卫生流行病学范畴，是精神医学的重要研究方向。

M2 精神障碍的症状学

A1型题

7. [batch007_M2_A1_001] 精神症状的正确定义是：

- A. 大脑器质性病变的神经系统体征
- B. 异常精神活动的外显行为表现 ☒
- C. 心理测验低于正常范围的指标
- D. 患者主观感受的躯体不适症状
- E. 社会适应不良导致的人际问题

答案：B | 记忆 | P10

解析：精神症状是异常精神活动通过言语、行为、情感等外显行为表现出来的现象。A属于神经科体征。

8. [batch007_M2_A1_002] 以下属于感觉障碍的是：

- A. 评论性幻听
- B. 感觉过敏 ☒
- C. 关系妄想
- D. 思维破裂
- E. 虚构症

答案：B | 记忆 | P11-P12

解析：感觉过敏属于感觉障碍（还包括感觉减退、倒错、内感性不适）。A是知觉障碍（幻觉），C是思维内容障碍（妄想），D是思维形式障碍，E是记忆障碍。

9. [batch007_M2_A1_003] 幻觉与错觉的根本区别在于：

- A. 幻觉发生在意识障碍时，错觉发生在意识清晰时
- B. 幻觉缺乏客观刺激物，错觉有客观刺激但被歪曲 ☒
- C. 幻觉仅见于精神分裂症，错觉可见于正常人群

- D. 幻觉持续时间较长，错觉持续时间短暂
- E. 幻觉内容固定不变，错觉内容经常变化

答案：B | 理解 | P12

解析：幻觉是缺乏客观刺激时的虚幻知觉；错觉是有客观刺激物存在但被歪曲的知觉。这是两者的根本鉴别点。

10. [batch007_M2_A1_004] 精神分裂症最具特征性的幻听类型是：

- A. 单纯的机械性声响如流水声
- B. 评论性、议论性及命令性幻听 ☒
- C. 听到自己思想被说出的体验
- D. 听到已故亲人呼唤的幻听
- E. 音乐旋律持续播放的非言语幻听

答案：B | 理解 | P12-P13

解析：评论性、议论性和命令性幻听是精神分裂症的特征性幻听类型，属于Schneider一级症状。

11. [batch007_M2_A1_005] 关于妄想的特点，描述正确的是：

- A. 对真实事件的合理推理
- B. 病理性歪曲信念，坚信不疑 ☒
- C. 可通过事实证据加以纠正
- D. 内容与患者个人经历无关
- E. 仅见于精神分裂症

答案：B | 理解 | P17-P20

解析：妄想是病理性歪曲的信念，患者坚信不疑，不受事实和说理纠正。可见于多种精神障碍，内容常与个人经历有关。

12. [batch007_M2_A1_006] 原发性妄想与继发性妄想的关键区别：

- A. 原发性内容荒谬，继发性内容合理
- B. 原发性突然发生不可理解，继发性基于其他病理基础 ☒
- C. 原发性持续终身，继发性可短期消失
- D. 原发性仅涉及被害内容
- E. 原发性对药物无效

答案：B | 理解 | P17

解析：原发性妄想突然发生、不可理解，对精神分裂症诊断价值高。继发性妄想是在幻觉、情感障碍等基础上产生的。

13. [batch007_M2_A1_007] 以下属于思维形式障碍的是：

- A. 被害妄想
- B. 思维奔逸 ☒
- C. 罪恶妄想
- D. 疑病妄想
- E. 钟情妄想

答案：B | 记忆 | P14-P17

解析：思维奔逸属于思维形式障碍（还包括迟缓、贫乏、散漫、破裂、插入等）。其余四项均为思维内容障碍（妄想）。

14. [batch007_M2_A1_008] 情感淡漠的主要临床特征是：

- A. 情绪波动剧烈，高涨与低落交替
- B. 对外界刺激缺乏相应的情感反应和内心体验 ☒
- C. 持续过度的担忧和紧张不安
- D. 情感反应与思维内容完全相反
- E. 微小刺激即引起强烈情绪爆发

答案：B | 理解 | P20-P22

解析：情感淡漠是对外界刺激缺乏相应情感反应，面部表情呆板、内心体验贫乏，是精神分裂症阴性症状的核心表现。D为情感倒错。

15. [batch007_M2_A1_009] 关于自知力的描述，最准确的是：

- A. 患者对姓名和身份的认识
- B. 患者对自身精神障碍的认识能力 ☒
- C. 对周围环境和时间的定向
- D. 记忆和回忆个人经历的能力
- E. 仅指是否愿意接受药物治疗

答案：B | 理解 | P23-P24

解析：自知力是患者对自身精神障碍的认识和判断能力，是判断病情严重程度、疗效和预后的重要指标。

16. [batch007_M2_A1_010] 定向力障碍中各维度受损的先后顺序是：

- A. 人物最先受损，地点最后受损
- B. 时间最先受损，人物最后受损 ✓
- C. 地点最先受损，时间最后受损
- D. 三者同时受损，无先后顺序
- E. 人物最先受损，时间最后受损

答案：B | 理解 | P24

解析：定向力障碍顺序：时间定向→地点定向→人物定向。时间最先受损，人物最晚受损。定向力障碍是意识障碍的重要标志。

17. [batch007_M2_A1_011] 思维破裂的主要特征是：

- A. 联想加速，话题随境转移
- B. 语句间缺乏逻辑联系，词语堆砌 ✓
- C. 思维过程突然中断
- D. 围绕主题添加大量不必要细节
- E. 将抽象概念具体化当做实物

答案：B | 理解 | P15-P16

解析：思维破裂是指意识清晰下语句间缺乏内在逻辑，形成词语杂拌，为精神分裂症特征性症状。A为思维奔逸，C为思维中断，D为病理性赘述，E为象征性思维。

18. [batch007_M2_A1_012] 蜡样屈曲最常见于：

- A. 抑郁性木僵
- B. 紧张性木僵 ✓
- C. 器质性木僵
- D. 心因性木僵
- E. 药源性木僵

答案：B | 理解 | P22-P23

解析：蜡样屈曲是紧张性木僵的特征性表现（肢体可任意摆布并维持姿势），属于紧张症综合征。

19. [batch007_M2_A2_001] 患者，男，22岁，近2个月独自对空说话、时而发笑。述“听到隔壁两个人在讨论我的一举一动，说我是废物”。此症状属：

- A. 错觉对真实声音的歪曲理解
- B. 议论性幻听讨论患者的行为品质 ☒
- C. 关系妄想认为别人言语与己有关
- D. 思维化声思想被他人说出
- E. 原发性妄想突然产生的信念

答案：B | 应用 | P12-P13

解析：听到两人讨论自己（“讨论我的一举一动”“说我是废物”），这是典型的议论性幻听，属言语性幻听，为精神分裂症特征性症状。

20. [batch007_M2_A2_002] 患者，女，35岁，坚信邻居在食物中下毒，多次化验阴性仍坚持并拒食。此症状最可能是：

- A. 被害妄想，坚信被他人迫害的信念 ☒
- B. 幻味，缺乏刺激时的味觉体验
- C. 超价观念，可理解的强烈信念
- D. 强迫思维，闯入性不由自主想法
- E. 疑病妄想，坚信患严重疾病

答案：A | 应用 | P17-P18

解析：坚信邻居下毒且不受客观证据纠正，是典型被害妄想。幻味是味觉异常体验，该患者主要表现为坚信被害而非味觉异常。

21. [batch007_M2_A2_003] 患者，男，28岁，近1周情绪高涨、说话滔滔不绝、话题随环境变换，称“精力无限，能当总统”。思维形式障碍是：

- A. 思维破裂，语句间完全缺乏逻辑
- B. 思维奔逸，联想加速话题不断变换 ☒
- C. 思维散漫，各句间有松散关联
- D. 病理性赘述，添加不必要细节
- E. 思维中断，思维过程中间停顿

答案：B | 应用 | P14-P15

解析：躁狂发作典型思维奔逸：联想加速、话题随境转移、夸大观念。思维奔逸是躁狂发作的核心思维形式障碍。

22. [batch007_M2_A2_004] 患者，男，40岁，近半年孤僻不与人交往、对家人漠不关心、对工作毫不在意。精神检查：表情呆板、言语贫乏。核心症状是：

- A. 抑郁心境持续低落伴兴趣减退
- B. 情感淡漠，缺乏情感反应和体验 ☒
- C. 意志增强，对特定事物异常执着
- D. 违拗症，对指令表现出抗拒
- E. 紧张症，木僵与兴奋交替

答案：B | 应用 | P20-P22

解析：孤僻、漠不关心、表情呆板、言语贫乏→情感淡漠+意志缺乏，是精神分裂症阴性症状的典型表现。

共用选项

- A. 被害妄想
- B. 关系妄想
- C. 夸大妄想
- D. 物理影响妄想
- E. 嫉妒妄想

23. [batch007_B1_01_Q1] 坚信周围人的言行都与自己有关，电视报纸内容都在影射自己

答案：B | 理解 | P17-P20

解析：标准答案：B

24. [batch007_B1_01_Q2] 坚信自己的思维和行为被外界仪器或电波控制

答案：D | 理解 | P17-P20

解析：标准答案：D

共用选项

- A. 言语性幻听
- B. 幻视（看到不存在的事物）
- C. 幻嗅（闻到不存在的气味）
- D. 幻触（皮肤蚁走感或触电感）
- E. 内脏幻觉

25. [batch007_B1_02_Q1] 谵妄状态中最常见的幻觉类型

答案：B | 理解 | P12-P14

解析：标准答案：B

26. [batch007_B1_02_Q2] 颞叶癫痫患者较常见的幻觉类型

答案：C | 理解 | P12-P14

解析：标准答案：C

共用选项

- A. 情感淡漠
- B. 思维破裂
- C. 意志缺乏
- D. 内感性不适
- E. 假性幻觉

27. [batch007_B1_08_Q1] 对周围事物缺乏情感反应，表情呆板，内心体验贫乏

答案：A | 应用 | P10-P24

解析：标准答案：A

28. [batch007_B1_08_Q2] 言语间完全缺乏逻辑联系，形成词语杂拌，意识清晰

答案：B | 应用 | P10-P24

解析：标准答案：B

X型题

29. [batch007_M2_X_001] 下列属于知觉障碍的是：

- A. 幻听
- B. 错觉
- C. 感觉过敏
- D. 内脏幻觉
- E. 感觉减退

答案：ABD | 记忆 | P11-P14

解析：幻听和内脏幻觉属于幻觉（知觉障碍），错觉也属知觉障碍。感觉过敏和感觉减退属

于感觉障碍。

30. [batch007_M2_X_002] 下列属于精神分裂症Schneider一级症状的是：

- A. 思维化声
- B. 评论性幻听
- C. 被动体验
- D. 妄想知觉
- E. 情感高涨

答案：ABCD | 记忆 | P14

解析：Schneider一级症状包括思维化声、争论性/评论性幻听、被动体验、妄想知觉等。E情感高涨是躁狂核心症状。

M3 神经认知障碍

A1型题

31. [batch007_M3_A1_001] 谵妄的核心临床特征是：

- A. 慢性进行性认知功能减退伴人格改变
- B. 急性波动性意识障碍伴注意力损害和认知异常 ☒
- C. 以近记忆严重受损为核心的遗忘综合征
- D. 反复发作的短暂意识丧失伴肢体抽搐
- E. 持续存在的系统化被害妄想和幻听

答案：B | 理解 | P222

解析：谵妄三大特征：急性起病（数小时至数天）、波动性病程（日轻夜重）、意识清晰度下降伴注意力和认知损害。A为痴呆，C为遗忘综合征。

32. [batch007_M3_A1_002] 谵妄的临床分型不包括：

- A. 高活动型
- B. 低活动型
- C. 混合型
- D. 进展型 ☒
- E. 活动过多型

答案：D | 记忆 | P223

解析：谵妄分为三型：高活动型（兴奋激动/幻觉妄想）、低活动型（安静嗜睡/易漏诊）、混

合型。无"进展型"分型。

33. [batch007_M3_A1_003] 阿尔茨海默病最具特征性的病理改变是：

- A. 多发性腔隙性脑梗死灶和白质疏松
- B. 老年斑沉积和神经原纤维缠结 ✓
- C. 路易小体在脑干和皮层沉积
- D. Pick小体在额颞叶形成
- E. 海绵状脑病伴朊蛋白沉积

答案：B | 理解 | P87-P90

解析：AD特征性病理：老年斑（ β -淀粉样蛋白沉积）+神经原纤维缠结（tau蛋白过度磷酸化）。A为VD，C为路易体痴呆，D为Pick病，E为朊蛋白病。

34. [batch007_M3_A1_004] AD与VD的鉴别要点中，支持血管性痴呆的是：

- A. 隐袭起病，缓慢进行性恶化
- B. 早期出现局灶性神经系统阳性体征 ✓
- C. MRI示弥漫性脑萎缩，海马显著受累
- D. Hachinski缺血评分 ≤ 4 分
- E. 早期以近记忆减退为核心，人格相对保留

答案：B | 理解 | P90-P91

解析：VD特征：阶梯样恶化、局灶神经体征、高血压/卒中史、影像学多发性梗死/白质病变、Hachinski ≥ 7 。A/C/D/E均符合AD表现。

35. [batch007_M3_A1_005] 遗忘综合征最典型的记忆损害模式是：

- A. 远记忆严重受损，近记忆保存
- B. 近记忆严重受损，远记忆和即刻记忆相对保存 ✓
- C. 即刻与近记忆同时受损，远记忆完整
- D. 三种记忆均等受损呈全面性遗忘
- E. 发作性遗忘伴选择性遗忘创伤事件

答案：B | 理解 | P85

解析：遗忘综合征以近记忆严重受损为核心，远记忆和即刻记忆相对保存，常伴虚构和定向障碍。常见于维生素B1缺乏。

36. [batch007_M3_A1_006] AD轻度阶段的核心特征为：

- A. 完全卧床，丧失语言和进食能力
- B. 近记忆减退为首发和核心表现，伴轻度人格改变 ☒
- C. 严重失语失用失认和锥体外系体征
- D. 视幻觉和波动性认知障碍为核心
- E. 进行性言语减少和额叶脱抑制症状

答案：B | 理解 | P88-P89

解析：AD轻度：近记忆减退为核心，伴轻度人格改变和空间定向障碍，日常生活基本自理。A为重度，C为中度阶段特征。

37. [batch007_M3_A1_007] 谵妄发病机制中最被广泛接受的神经递质假说是：

- A. 多巴胺亢进和去甲肾上腺素低下假说
- B. 胆碱能功能低下和多巴胺能过度活动假说 ☒
- C. 5-HT亢进和谷氨酸能低下假说
- D. GABA功能低下和谷氨酸亢进假说
- E. 组胺能亢进和乙酰胆碱过多假说

答案：B | 理解 | P222

解析：胆碱能功能低下-多巴胺能过度活动假说是谵妄发病机制中最被广泛接受的假说。抗胆碱能药物可诱发谵妄支持此假说。

38. [batch007_M3_A1_008] 谵妄的危险因素中，属于素质性因素的是：

- A. 急性感染如肺炎或泌尿系统感染
- B. 高龄和既往存在的痴呆病史 ☒
- C. 抗胆碱能药物的不良反应
- D. 代谢紊乱如电解质异常或肝衰竭
- E. 急性脑卒中和颅脑外伤

答案：B | 记忆 | P222

解析：谵妄危险因素：素质性因素（高龄/痴呆/基础疾病/感觉障碍）；诱因（感染/药物/代谢/脑部疾病）。高龄和痴呆属于素质性因素。

39. [batch007_M3_A1_009] 躯体疾病所致精神障碍的诊断原则中，最关键的是：

- A. 精神症状必须达到精神病性水平

- B. 确定躯体疾病在前而精神症状在后的因果关系 ☒
- C. 精神症状对药物和非药物治疗有效
- D. 躯体疾病好转后精神症状随之消失
- E. 精神症状必须持续超过六个月出现

答案：B | 理解 | P92-P93

解析：核心诊断原则：确立躯体疾病与精神症状的因果关系——躯体疾病在前、精神症状在后，且随躯体疾病波动而变。

40. [batch007_M3_A1_010] MMSE主要评估的功能是：

- A. 人格特征和心理防御机制
- B. 认知功能的快速筛查 ☒
- C. 精神分裂症症状严重程度
- D. 抑郁焦虑情绪严重程度
- E. 睡眠质量和失眠程度

答案：B | 理解 | P31

解析：MMSE（简易精神状态检查）是认知功能障碍的筛查工具，评估定向力、记忆力、注意力和计算力、回忆能力、语言能力，总分30分。

A2型题

41. [batch007_M3_A2_001] 患者，男，72岁，发热咳嗽3天入院。住院第2天晚间兴奋躁动、胡言乱语、不认识家人、拉扯输液管。次日早晨精神完全正常。最可能诊断：

- A. 阿尔茨海默病早期
- B. 谵妄，由感染诱发且呈波动性病程 ☒
- C. 晚发性精神分裂症
- D. 血管性痴呆急性发作
- E. 双相障碍躁狂发作

答案：B | 应用 | P222-P223

解析：老年男性，感染诱因，急性起病，波动性病程（晚间兴奋→次日早晨正常），意识障碍+定向障碍，典型谵妄表现。

42. [batch007_M3_A2_002] 患者，女，68岁，近2年记忆逐渐变差，忘记刚说过的话，无法独立购物，尚能自理。无局灶神经体征。MRI示双侧海马萎缩。Hachinski评分3分。最可能诊断：

- A. 血管性痴呆
- B. 阿尔茨海默病 ✓
- C. 路易体痴呆
- D. 正常压力脑积水
- E. 额颞叶痴呆

答案：B | 应用 | P87-P90

解析：隐袭起病、进行性恶化（2年）、近记忆减退为核心、海马萎缩（典型AD影像）、Hachinski≤4、无局灶体征，符合AD。

43. [batch007_M3_A2_003] 患者，男，65岁，饮酒30年。近1年记不住刚发生的事，有时编造虚假经历回答提问。查体：双侧眼球活动受限、步态不稳。最可能诊断：

- A. 阿尔茨海默病（渐进性记忆减退和认知下降）
- B. Wernicke-Korsakoff综合征 ✓
- C. 血管性痴呆（阶梯样恶化、局灶神经体征）
- D. 额颞叶痴呆（人格改变、行为脱抑制）
- E. 路易体痴呆（波动性认知、视幻觉、帕金森）

答案：B | 应用 | P85, P191

解析：长期饮酒+近记忆严重受损+虚构（Korsakoff）+眼球活动受限+共济失调（Wernicke三联征）→Wernicke-Korsakoff综合征，维生素B1缺乏所致。

44. [batch007_M3_A2_004] 患者，男，78岁，高血压20年。半年前脑梗后出现记忆力下降，此后呈阶梯样加重。查体：右侧鼻唇沟变浅、右侧肢体轻瘫。认知障碍最可能为：

- A. 阿尔茨海默病性痴呆
- B. 血管性痴呆 ✓
- C. 路易体痴呆
- D. 正常压力脑积水
- E. 额颞叶痴呆

答案：B | 应用 | P90-P91

解析：高血压+脑梗史+阶梯样恶化+局灶神经体征（面瘫+肢瘫），符合血管性痴呆的多发梗死性痴呆特点。

45. [batch007_M3_A2_005] 谵妄与痴呆的快速鉴别要点中，谵妄的特点为：

- A. 起病隐袭，病程缓慢进行性加重

- B. 急性起病数小时内，意识清晰度波动性下降 
- C. 早期无意识障碍，注意力定向力正常
- D. 以远记忆损害为主，人格早期改变
- E. 病程稳定不随时间变化而波动

答案：B | 应用 | P222-P228

解析：谵妄vs痴呆：谵妄=急性起病+意识波动↓+注意力严重障碍+视幻觉常见+通常可逆；
痴呆=隐袭起病+早期意识清晰+注意力正常+通常不可逆。

共用选项

- A. 谵妄
- B. 阿尔茨海默病痴呆
- C. 抑郁假性痴呆
- D. 遗忘综合征
- E. 路易体痴呆

46. [batch007_B1_03_Q1] 急性起病，波动性意识障碍，视幻觉丰富，症状昼轻夜重

答案：A | 应用 | P222-P228

解析：标准答案：A

47. [batch007_B1_03_Q2] 老年患者，情绪低落，自称"记性差"但测试时回答"不知道"，抗抑郁治疗后认知改善

答案：C | 应用 | P222-P228

解析：标准答案：C

X型题

48. [batch007_M3_X_001] 谵妄的常见临床表现包括：

- A. 意识水平波动，日轻夜重
- B. 注意障碍，注意力难以集中维持
- C. 认知损害，涉及记忆定向力语言视空间
- D. 精神运动紊乱，可高活动或低活动型
- E. 睡眠觉醒周期紊乱，昼夜颠倒夜重

答案：ABCD | 理解 | P223

解析：谵妄五大维度：意识水平波动+注意障碍+认知损害+精神运动紊乱+睡眠-觉醒障碍。

以上全属于谵妄临床表现。

49. [batch007_M3_X_002] 支持血管性痴呆而非AD的临床证据包括：

- A. 起病突然或阶梯样恶化
- B. 早期出现局灶性神经体征
- C. 有明确高血压和脑血管意外病史
- D. 影像学示多发梗死灶或白质病变
- E. Hachinski缺血评分 ≥ 7 分

答案：ABCD | 分析 | P90-P91

解析：VD vs AD五大鉴别点：突然/阶梯起病、局灶神经体征、脑血管危险因素、影像梗死/白质病变、Hachinski ≥ 7 。AD则为隐袭起病、无局灶体征、弥漫萎缩、Hachinski ≤ 4 。

M4 精神活性物质所致精神障碍

A1型题

50. [batch007_M4_A1_001] 药物依赖（成瘾）的核心特征是：

- A. 单纯生理需求增加，无戒断症状
- B. 强制性使用、失控、耐受性增加与戒断症状 ☒
- C. 仅有心理渴求，无躯体依赖的反复使用
- D. 偶尔药物使用导致了不良社会法律后果
- E. 遵医嘱规律服用处方药产生生理耐受

答案：B | 理解 | P180

解析：依赖核心特征：强制性使用+失控+耐受性增加+戒断症状，分心理依赖（渴求）和躯体依赖（戒断）。D对应滥用概念。

51. [batch007_M4_A1_002] 耐受性的定义是：

- A. 首次用药即产生强烈效应
- B. 重复使用后药效降低，需加大剂量才能获得原有效应 ☒
- C. 停药后出现躯体和心理症状
- D. 对药物产生强烈心理渴求和觅药行为
- E. 使用药物后出现既往未有的不良反应

答案：B | 记忆 | P180

解析：耐受性指重复使用后药效降低，需增加剂量才能获得原有效应。C为戒断症状，D为

52. [batch007_M4_A1_003] 酒精依赖最具特征性的行为模式是：

- A. 偶尔社交场合饮酒，量不固定
- B. 特定饮酒模式伴晨饮、觅酒行为、屡戒屡败 ☒
- C. 仅在心情不好时饮酒缓解情绪
- D. 饮酒量逐渐减少，不再出现戒断
- E. 仅在节假日饮用少量低度酒精饮品

答案：B | 理解 | P190

解析：酒精依赖特征：特定饮酒模式（定时/定量）+晨饮（夜间戒断后晨起饮酒）+觅酒行为+屡戒屡败+耐受性↑+戒断症状。

53. [batch007_M4_A1_004] 震颤谵妄通常在末次饮酒后多久出现：

- A. 6至12小时
- B. 48至96小时 ☒
- C. 2至4小时
- D. 1至2周
- E. 24至48小时

答案：B | 理解 | P191

解析：震颤谵妄出现于末次饮酒后48-96h（2-4天），表现意识障碍+粗大震颤+自主神经亢进+幻觉，死亡率约5%。A为单纯戒断（6-12h），E为酒精性癫痫（24-48h）。

54. [batch007_M4_A1_005] Wernicke脑病的经典三联征是：

- A. 眼球震颤、意向性震颤、构音障碍
- B. 眼肌麻痹、共济失调、意识障碍 ☒
- C. 近记忆减退、虚构症、定向力障碍
- D. 视幻觉、被害妄想、行为紊乱
- E. 失语症、失用症、失认症

答案：B | 理解 | P191

解析：Wernicke脑病三联征：眼肌麻痹+共济失调+意识障碍。维生素B1缺乏所致，紧急静脉补充B1是关键治疗。

55. [batch007_M4_A1_006] 酒精戒断性癫痫通常出现在末次饮酒后：

- A. 6至12小时
- B. 12至24小时
- C. 24至48小时 ☒
- D. 48至96小时
- E. 2至4小时

答案：C | 理解 | P191

解析：酒精戒断时间线：6-12h→单纯戒断，12-24h→酒精性幻觉症，24-48h→酒精性癫痫（~30%患者），48-96h→震颤谵妄。

56. [batch007_M4_A1_007] 酒精戒断综合征的首选治疗药物类别是：

- A. 第一代抗精神病药
- B. 苯二氮草类 ☒
- C. SSRI类抗抑郁药
- D. 心境稳定剂碳酸锂
- E. 中枢兴奋剂

答案：B | 记忆 | P191

解析：酒精戒断首选苯二氮草类（地西泮/氯硝西泮）替代递减，机制为GABA-A受体交叉耐受。同时补充维生素B1预防Wernicke脑病。

57. [batch007_M4_A1_008] 精神活性物质滥用与依赖的核心区别：

- A. 滥用仅涉及非法毒品，依赖可涉及合法物质
- B. 滥用反复使用致不良后果，无明显耐受性和戒断 ☒
- C. 滥用必致躯体疾病，依赖仅致心理问题
- D. 滥用仅见于青少年，依赖可见于任何年龄
- E. 滥用心理治疗即可，依赖必须药物干预

答案：B | 理解 | P180

解析：滥用：反复使用致不良后果（社会/法律/职业），但无明显耐受性增加和戒断症状。
依赖：在滥用基础上+耐受性↑+戒断症状。

A2型题

58. [batch007_M4_A2_001] 患者，男，45岁，酗酒15年。自行戒酒后意识模糊伴全身粗大震颤1天。T38.5°C，大汗，HR120次/分，BP160/100mmHg，意识模糊伴视幻觉，四肢粗大震颤。最可能诊断：

- A. Wernicke脑病
- B. 震颤谵妄 ☒
- C. 酒精性幻觉症
- D. 酒精戒断性癫痫
- E. 恶性综合征

答案：B | 应用 | P191

解析：酗酒15年+戒酒后+意识模糊+粗大震颤+发热+大汗+HR↑BP↑（自主神经亢进）+视幻觉，符合震颤谵妄全部特征。死亡率约5%。

59. [batch007_M4_A2_002] 患者，男，50岁，酗酒30年。近1年近记忆下降，常忘记刚发生的事，有时编造虚假经历。查体：双侧眼球外展受限、步态不稳。最紧急的处理是：

- A. 给予大剂量抗精神病药控制精神症状
- B. 紧急静脉注射大剂量维生素B1 ☒
- C. 口服多奈哌齐改善认知功能
- D. 苯二氮䓬类替代递减治疗
- E. 口服纳曲酮降低酒精渴求

答案：B | 应用 | P191

解析：长期酗酒+近记忆严重受损+虚构（Korsakoff）+眼球外展受限+共济失调（Wernicke三联征）→Wernicke-Korsakoff综合征，紧急补充维生素B1是关键。

60. [batch007_M4_A2_003] 患者，男，38岁，海洛因依赖5年。停用后6小时出现流泪、流涕、打哈欠、出汗、全身酸痛、焦虑不安。此症状属于：

- A. 海洛因急性中毒
- B. 阿片类戒断综合征 ☒
- C. 苯丙胺类戒断反应
- D. 酒精戒断早期症状
- E. 苯二氮䓬类戒断反应

答案：B | 应用 | P180

解析：海洛因（阿片类）戒断后6-8h出现流泪/流涕/打哈欠/出汗/全身酸痛/焦虑，虽主观痛苦严重但通常不直接危及生命。

61. [batch007_M4_A2_004] 酒精所致精神障碍的治疗原则中，不包括以下哪项：

- A. 苯二氮䓬类替代递减治疗戒断症状
- B. 补充维生素B1预防Wernicke脑病
- C. 长期使用抗精神病药治疗酒精性幻觉症 ☒
- D. 加强营养支持维持水电解质平衡
- E. 心理社会康复促进长期戒酒康复

答案：C | 应用 | P191

解析：酒精性幻觉症多为自限性，可短期对症使用抗精神病药但非长期治疗。核心治疗：BZD替代递减+B1补充+支持营养+心理社会康复。

病例

患者，男，52岁，酗酒20年。因"自行戒酒3天后出现意识模糊、全身粗大震颤1天"入院。
查体：T 38.5°C，大汗，HR 120次/分，BP 160/100mmHg。意识模糊，不认识家人，拉扯输液管，见视幻觉（称"看到蛇在墙角爬"）。四肢粗大震颤。

62. [batch007_v3_EXT_A3_004_Q1] 该患者最可能的诊断是：

- A. Wernicke脑病
- B. 酒精性幻觉症
- C. 酒精戒断震颤谵妄 ☒
- D. 恶性综合征
- E. 酒精戒断性癫痫发作

答案：C | 应用

解析：酗酒20年+自行戒酒3天（48-96h窗口）+意识模糊+粗大震颤+高热+大汗+HR↑BP↑（自主神经亢进）+视幻觉→典型震颤谵妄，死亡率约5%。A为维生素B1缺乏三联征（眼肌麻痹/共济失调/意识障碍）。

63. [batch007_v3_EXT_A3_004_Q2] 该患者的首选紧急处理是：

- A. 氟哌啶醇肌注控制幻觉和兴奋
- B. 苯二氮䓬类静脉给药如地西泮 ☒
- C. 立即行血液透析清除体内毒素
- D. 约束保护等待症状自行缓解
- E. 纳曲酮口服降低酒精渴求

答案：B | 应用

解析：震颤谵妄首选苯二氮䓬类（地西泮/劳拉西泮）静脉给药替代递减，机制为GABA-A

受体交叉耐受。同时补充大剂量维生素B1（预防Wernicke脑病）、支持治疗（补液/纠正电解质/监护）。A抗精神病药降低癫痫阈值慎用。

64. [batch007_v3_EXT_A3_004_Q3] 急性期过后长期治疗的核心目标是：

- A. 长期服用苯二氮草类替代
- B. 预防复饮维持戒酒联合社会心理康复 ☒
- C. 长期服用抗精神病药
- D. 仅定期门诊随访不需其他干预
- E. 长期服用纳曲酮即可

答案：B | 应用

解析：长期治疗核心：预防复饮+维持戒酒+社会心理康复（AA/动机增强/CBT）。纳曲酮/阿坎酸/双硫仑可作为辅助防复饮。A BZD长期使用有依赖风险应避免；C仅为对症非长期。

65. [batch007_v3_EXT_A3_004_Q4] 使用苯二氮草类治疗时需特别注意：

- A. BZD无任何副作用可长期安全使用
- B. 呼吸抑制风险尤其在年老体弱或肝功能不全者 ☒
- C. BZD可突然停药而不产生戒断症状
- D. BZD需与酒精同时使用以增强疗效
- E. BZD主要经肾脏排泄无需关注肝功能

答案：B | 应用

解析：BZD治疗注意事项：①呼吸抑制风险（尤其静脉给药/年老/体弱/肝功能不全/COPD患者需减量）；②依赖和戒断风险需替代递减；③过度镇静/跌倒风险。A/C/D/E均有错误。

共用选项

- A. 阿片类中毒
- B. 阿片类戒断
- C. 苯丙胺类中毒
- D. 酒精戒断震颤谵妄
- E. 苯二氮草类戒断

66. [batch007_B1_04_Q1] 意识模糊伴粗大震颤、大汗、心率增快、视幻觉，见于长期酗酒者突然停饮后2-4天

答案：D | 应用 | P180-P191

解析：标准答案：D

67. [batch007_B1_04_Q2] 瞳孔缩小、呼吸抑制、意识障碍、针尖样瞳孔

答案：A | 应用 | P180-P191

解析：标准答案：A

X型题

68. [batch007_M4_X_001] 震颤谵妄的典型临床表现包括：

- A. 意识障碍表现为意识模糊
- B. 粗大震颤累及肢体和躯干
- C. 自主神经亢进：大汗、心慌、血压升高
- D. 生动的视幻觉常伴听幻觉
- E. 发热、白细胞升高，死亡率约5%

答案：ABCD | 理解 | P191

解析：震颤谵妄为酒精戒断最严重形式：意识障碍+粗大震颤+自主神经亢进+幻觉（以视幻觉为主）+发热，死亡率约5%，需住院监护。

69. [batch007_M4_X_002] 关于药物依赖的临床特征，正确的有：

- A. 心理依赖表现为对药物的强烈渴求和觅药行为
- B. 躯体依赖表现为停药后出现戒断症状综合征
- C. 耐受性表现为重复用药后原有效应逐渐降低
- D. 依赖的诊断要求心理依赖和躯体依赖同时具备
- E. 核心特征包括失控性使用并忽视不良后果

答案：ABCE | 记忆 | P180

解析：心理依赖+躯体依赖+耐受性↑+失控使用是依赖核心特征。D错误：心理和躯体依赖不一定同时出现（如可卡因以心理依赖为主）。

M5 精神分裂症及其他精神病性障碍

A1型题

70. [batch007_M5_A1_001] 精神分裂症的终生患病率约为：

- A. 0.1%
- B. 1% ✓
- C. 0.5%
- D. 5%
- E. 0.3%

答案：B | 记忆 | P71

解析：精神分裂症终生患病率约1%，男女发病率相当但男性起病更早（15-25岁 vs 女性25-35岁）。

71. [batch007_M5_A1_002] 精神分裂症的遗传模式是：

- A. 单基因常染色体显性遗传
- B. 多基因遗传，一级亲属患病风险约10% ✓
- C. 与遗传完全无关的表现
- D. 性染色体连锁遗传
- E. 线粒体母系遗传的表现

答案：B | 理解 | P71-P72

解析：精神分裂症为多基因遗传，一级亲属患病风险约10%（显著高于普通人群1%），同卵双生子同病率约50%。

72. [batch007_M5_A1_003] 多巴胺假说中，中脑边缘通路DA亢进主要解释哪组症状：

- A. 阳性症状如幻觉妄想和思维形式障碍 ✓
- B. 阴性症状如情感淡漠和社交退缩
- C. 认知症状如注意力和执行功能损害
- D. 情感症状如焦虑和抑郁心境
- E. 锥体外系反应如肌张力障碍

答案：A | 理解 | P72

解析：中脑边缘通路DA亢进→阳性症状（幻觉/妄想）；前额叶DA功能低下→阴性症状和认知症状。E为药物副作用（D2阻断）。

73. [batch007_M5_A1_004] 神经发育假说认为精神分裂症发病的关键时期是：

- A. 成年后脑部感染引起获得性疾病

- B. 孕期围产期脑损伤+青春期突触修剪异常共同导致 ☒
- C. 完全由后天社会心理因素应激导致
- D. 单一基因突变导致神经元凋亡所致
- E. 神经递质急性失衡的一过性障碍

答案：B | 理解 | P72

解析：神经发育假说：孕期/围产期脑损伤（遗传+环境）→青春期突触过度修剪异常→发病。解释了青壮年起病的原因。

74. [batch007_M5_A1_005] 精神分裂症三组核心症状中，最能判断预后的指标是：

- A. 阳性症状的丰富程度
- B. 阴性症状的严重程度
- C. 认知症状的损害程度 ☒
- D. 情感症状的波动程度
- E. 行为紊乱的严重程度

答案：C | 理解 | P73

解析：认知症状（注意/记忆/执行功能损害）是判断预后的最重要指标，且当前治疗改善有限。阳性症状药物反应较好。

75. [batch007_M5_A1_006] 精神分裂症发作期自知力的特点为：

- A. 始终完整不受疾病影响
- B. 发作期常缺乏自知力，影响治疗依从性 ☒
- C. 仅在恢复期才出现轻度短暂受损
- D. 自知力完好是诊断的必要条件
- E. 仅阴性症状为主的患者中受损

答案：B | 理解 | P73

解析：发作期常缺乏自知力（不承认有病/拒绝治疗），是影响治疗依从性的重要因素。自知力恢复是判断疗效和预后的指标。

76. [batch007_M5_A1_007] 以下哪项不属于精神分裂症Schneider一级症状：

- A. 思维化声
- B. 议论性幻听
- C. 被动体验
- D. 妄想知觉

- E. 情感高涨 ☒

答案：E | 记忆 | P14, P74

解析：Schneider一级症状：思维化声、评论性/议论性幻听、被动体验、妄想知觉等。E情感高涨是躁狂发作核心症状，为阴性选项（不属于一级症状）。

77. [batch007_M5_A1_008] 精神分裂症最常见的临床亚型是：

- A. 青春型
- B. 偏执型 ☒
- C. 紧张型
- D. 单纯型
- E. 未分化型

答案：B | 记忆 | P76

解析：偏执型最常见，以妄想（尤其被害妄想）和幻听为核心，起病较晚（青壮年），预后相对较好。

78. [batch007_M5_A1_009] 精神分裂症青春型的核心临床表现是：

- A. 中年起病，妄想和幻听为核心
- B. 青少年起病，思维破裂、情感倒错、行为怪异 ☒
- C. 木僵与兴奋交替的紧张症状
- D. 缓慢进展的阴性症状，无明显阳性
- E. 急性起病，短期内完全缓解

答案：B | 理解 | P77

解析：青春型（解体型）：青少年起病，思维破裂（词语杂拌）、情感倒错、行为怪异愚蠢，预后较差。

79. [batch007_M5_A1_010] 精神分裂症单纯型的主要特征是：

- A. 急性起病，丰富的幻觉妄想
- B. 缓慢进展，阴性症状为主，无明显阳性症状 ☒
- C. 青春期起病，思维破裂情感倒错
- D. 木僵与兴奋交替的紧张症状
- E. 中年起病，系统化被害和嫉妒妄想

答案：B | 理解 | P77

解析：单纯型：隐袭起病、缓慢进展，以阴性症状（情感淡漠/意志减退/社交退缩）为主，无明显阳性症状，预后最差。

80. [batch007_M5_A1_011] 一代与二代抗精神病药在机制上的主要区别是：

- A. 一代阻断H1受体，二代阻断D2受体
- B. 一代主要阻断D2受体，二代为5-HT_{2A}与D2双重阻断 ✓
- C. 一代为D1激动剂，二代为非选择性拮抗剂
- D. 一代仅作用外周，二代可进入中枢
- E. 一代通过GABA系统，二代通过谷氨酸系统

答案：B | 理解 | P76, P291-P292

解析：一代主要阻断D2受体→控制阳性症状但EPS明显；二代为5-HT_{2A}+D2双重阻断→改善阴性/认知症状、EPS较少。

81. [batch007_M5_A1_012] 长期用药后出现且最难以治疗的EPS类型是：

- A. 急性肌张力障碍
- B. 静坐不能
- C. 帕金森综合征
- D. 迟发性运动障碍 ✓
- E. 恶性综合征

答案：D | 理解 | P292

解析：EPS四型中，迟发性运动障碍（TD）在长期用药后出现，口-舌-颊不自主运动，常不可逆且难以治疗。E恶性综合征不属EPS四型。

82. [batch007_M5_A1_013] 氯氮平的独特地位基于：

- A. 作为所有首发患者的一线首选
- B. 用于难治性精神分裂症，需监测粒细胞缺乏风险 ✓
- C. 因无副作用而作为儿童首选
- D. 仅用于急性期控制兴奋
- E. 作为单药无效时的常规联合用药

答案：B | 记忆 | P76, P293

解析：氯氮平用于难治性精神分裂症（≥2种其他抗精神病药足量足疗程无效），疗效优于其他药物但存在粒细胞缺乏风险（1-2%），前18周每周监测血象。

83. [batch007_M5_A1_014] 精神分裂症维持治疗的原则是：

- A. 症状消失后立即停药
- B. 首发至少1-2年，复发至少5年或终身，最低有效剂量 ☒
- C. 仅阳性症状时临时用药
- D. 所有患者终身服用最大剂量
- E. 维持期换用一代药物降低费用

答案：B | 理解 | P76

解析：维持治疗：首发至少1-2年；复发者至少5年或终身；最低有效剂量。不规律服药或过早停药是复发的重要原因。

84. [batch007_M5_A1_015] 妄想性障碍的核心特征为：

- A. 持久妄想 ≥ 3 月，无明显幻觉 ☒
- B. 丰富幻听和思维破裂，急性起病
- C. 阴性症状为主，缓慢进展
- D. 情感症状为主导，有躁狂或抑郁
- E. 认知功能全面减退，隐袭起病加重

答案：A | 理解 | P78

解析：妄想性障碍：持久妄想（ ≥ 3 月）、妄想内容系统化、无精神分裂症其他典型症状、无明显幻觉或偶有相关幻觉。

85. [batch007_M5_A1_016] 急性短暂性精神病性障碍的病程特点是：

- A. 隐袭起病，持续数年不可缓解
- B. 急性起病 ≤ 2 周，病程1-3月可完全缓解 ☒
- C. 反复发作，每次持续6个月以上
- D. 缓慢起病，持续超一年，药物无效
- E. 间歇发作持续数年，每次表现不同

答案：B | 理解 | P79

解析：急性短暂性精神病性障碍：急性起病（ ≤ 2 周）、病程1天至1-3月、完全缓解、预后良好。与精神分裂症的关键区别在病程和转归。

86. [batch007_M5_A1_017] 精神分裂症预后良好的指标包括：

- A. 缓慢起病，阴性症状为主，病前功能差
- B. 急性起病，治疗及时，依从性好，病前功能良好 ☒
- C. 男性，起病年龄早，有家族遗传史
- D. 认知损害突出，药物反应差
- E. 合并物质滥用，社会支持差

答案：B | 理解 | P76

解析：良好预后指标：急性起病、治疗及时、依从性好、病前功能良好、女性、已婚、社会支持好。A/C/D/E均为不良预后指标。

87. [batch007_M5_A1_018] 精神分裂症前驱期表现不包括：

- A. 社交退缩和兴趣下降
- B. 古怪行为和异常观念但未达精神病性程度
- C. 持续≥1月的评论性幻听和被害妄想 ☒
- D. 学习成绩下降和社会功能轻度受损
- E. 多疑敏感和偶发超价观念

答案：C | 理解 | P82

解析：前驱期为非特异性症状（社交退缩/古怪行为/多疑等），尚未达精神病性诊断标准。C（持续≥1月特征性精神病性症状）已满足诊断标准，不属于前驱期。

88. [batch007_M5_A1_019] 对体重增加和代谢综合征影响最显著的抗精神病药是：

- A. 氟哌啶醇
- B. 奥氮平和氯氮平 ☒
- C. 阿立哌唑
- D. 齐拉西酮
- E. 奋乃静制剂

答案：B | 理解 | P292-P293

解析：奥氮平和氯氮平在所有抗精神病药中体重增加和代谢综合征风险最高。阿立哌唑和齐拉西酮代谢影响较小。

89. [batch007_M5_A1_020] 精神分裂症与心境障碍鉴别时，支持分裂症的是：

- A. 情感高涨与夸大妄想同时出现，间歇期恢复良好
- B. 精神病性症状出现在情感症状之前，独立于心境变化 ☒
- C. 抑郁与罪恶妄想相伴，抗抑郁药反应良好

- D. 间歇期精神状态完全恢复正常无残留
- E. 精神症状与情感症状持续时间一致

答案：B | 理解 | P80

解析：核心鉴别：分裂症的精神病性症状出现在情感症状之前或独立于心境变化。A为双相躁狂，C为抑郁。

A2型题

90. [batch007_M5_A2_001] 患者，男，23岁，大学生。近2月成绩下降、不愿交往。近2周自语自笑，称“听到国家领导人在讨论我的未来，说我肩负特殊使命”，坚信同学在背后议论他。最可能诊断：

- A. 双相障碍躁狂发作
- B. 精神分裂症偏执型 ☒
- C. 急性短暂性精神病性障碍
- D. 妄想性障碍
- E. 分裂情感性障碍

答案：B | 应用 | P71-P76

解析：青年男性，前驱期（成绩下降/社交退缩2月），特征性症状：评论性幻听+被害/夸大妄想，符合偏执型诊断。病程>1月。

91. [batch007_M5_A2_002] 患者，女，19岁。半年前开始孤僻不交往，对上课毫不在意。近1月完全不说话，终日卧床，表情呆板。将其手臂抬起后可维持该姿势数分钟不掉。此症状为：

- A. 抑郁性木僵
- B. 紧张性木僵伴蜡样屈曲 ☒
- C. 违拗症状（对指令做出相反反应）
- D. 缄默症状（虽能言语但拒不开口）
- E. 意志减退（主动性和动力下降）

答案：B | 应用 | P22-P23, P77

解析：木僵（完全不动/不语）+蜡样屈曲（手臂抬起后维持姿势），属于典型紧张症综合征。阴性症状+紧张症状，多见于分裂症紧张型。

92. [batch007_M5_A2_003] 患者，男，25岁。3月前出现怪异行为，称“电脑在监控我的思想，我脑子里想什么电脑屏幕上就会显示出来”。此症状为：

- A. 夸大妄想
- B. 被洞悉感 ☒
- C. 思维插入
- D. 物理影响妄想
- E. 关系妄想

答案：B | 应用 | P18-P19

解析："脑子里想什么电脑屏幕上就会显示出来"→思想被他人知晓，符合被洞悉感（思维被洞悉/思维扩散），属分裂症特征性症状。

93. [batch007_M5_A2_004] 患者，女，30岁，确诊分裂症3年，服利培酮4mg/d维持。近1月口唇舌部不自主蠕动和咀嚼样动作，紧张加重睡眠消失。最可能是：

- A. 急性肌张力障碍
- B. 迟发性运动障碍 ☒
- C. 帕金森综合征
- D. 静坐不能
- E. 恶性综合征

答案：B | 应用 | P292

解析：长期用药（3年）+口-舌-颊不自主运动（蠕动/咀嚼）+紧张加重/睡眠消失，符合迟发性运动障碍（TD）典型表现。常不可逆。

94. [batch007_M5_A2_005] 患者，男，22岁。近2年生活懒散、不修边幅、不交往、对家人冷漠。精神检查：言语贫乏、表情呆板。否认幻觉妄想。最符合的亚型：

- A. 偏执型
- B. 青春型
- C. 紧张型
- D. 单纯型 ☒
- E. 未分化型

答案：D | 应用 | P77

解析：缓慢进展（2年）+阴性症状为主（懒散/冷漠/言语贫乏/表情呆板）+无阳性症状（否认幻觉/妄想），符合单纯型，预后最差。

95. [batch007_M5_A2_006] 患者，男，30岁，确诊分裂症5年，先后用利培酮和奥氮平足量足疗程无效，仍有持续评论性幻听和被害妄想。下一步最合适的方案：

- A. 继续增加奥氮平至最大耐受剂量
- B. 换用氯氮平，前18周每周监测血象 ☒
- C. 停药改用心理治疗单一行治疗
- D. 联合两种一代抗精神病药增强疗效
- E. 仅给予苯二氮䓬类控制焦虑失眠

答案：B | 应用 | P76

解析：难治性分裂症（≥2种不同抗精神病药足量足疗程无效）应换用氯氮平，需监测粒细胞缺乏（前18周每周查血象）。

病例

患者，男，23岁，大学生。近2月成绩下降、不愿交往。近2周出现自语自笑，称“听到国家领导人在讨论我的未来”，坚信同学在背后议论他。精神检查未见情感高涨或低落。

96. [batch007_v3_EXT_A3_001_Q1] 该患者最可能的诊断是：

- A. 双相障碍躁狂发作
- B. 精神分裂症偏执型 ☒
- C. 妄想性障碍
- D. 急性短暂性精神病性障碍
- E. 分裂情感性障碍

答案：B | 应用

解析：青年男性，前驱期（成绩下降/社交退缩2月），特征性评论性幻听（“听到国家领导人在讨论”）+被害/夸大妄想，病程>1月，情感协调，符合精神分裂症偏执型。A有心境高涨但本例缺乏；C妄想系统但本例有明显幻听；D病程<2周。

97. [batch007_v3_EXT_A3_001_Q2] 该患者的首选治疗药物类别是：

- A. SSRI类抗抑郁药
- B. 苯二氮䓬类镇静药物
- C. 第二代非典型抗精神病药 ☒
- D. 碳酸锂心境稳定剂
- E. 中枢神经兴奋剂

答案：C | 应用

解析：首发精神分裂症首选第二代（非典型）抗精神病药，如利培酮、奥氮平、阿立哌唑等。5-HT_{2A}+D₂双重阻断，对阳性症状有效且EPS较少。A为抗抑郁药；D用于双相而非分裂症一线。

98. [batch007_v3_EXT_A3_001_Q3] 若选用利培酮治疗，早期最需关注的副作用是：

- A. 严重肝功能损害
- B. 粒细胞缺乏症
- C. 锥体外系反应EPS ☒
- D. 5-HT综合征
- E. 锂盐中毒反应

答案：C | 应用

解析：利培酮D2阻断作用较强，EPS（急性肌张力障碍/静坐不能/帕金森综合征/迟发性运动障碍）是早期最常见副作用，尤其剂量>4mg/d时。B为氯氮平特有风险；D为SSRI+MAOI联用风险；E与锂盐相关。

99. [batch007_v3_EXT_A3_001_Q4] 治疗4周后幻听减轻但体重增加5kg、空腹血糖6.8mmol/L，此时最恰当的处理是：

- A. 继续利培酮，加用二甲双胍
- B. 换用代谢副作用较小的药物如阿立哌唑 ☒
- C. 停用所有抗精神病药观察
- D. 加用氟哌啶醇联合治疗
- E. 继续利培酮，不予特殊处理

答案：B | 应用

解析：利培酮引起显著体重增加和血糖升高（代谢综合征），应换用代谢副作用较小的药物如阿立哌唑（D2部分激动剂，代谢影响小）、齐拉西酮。A可作为辅助但非首选方案；C停药风险大（复发）；D会增加EPS风险；E忽视代谢问题不当。

共用选项

- A. 氟哌啶醇
- B. 利培酮
- C. 氯氮平
- D. 奥氮平
- E. 阿立哌唑

100. [batch007_B1_05_Q1] EPS风险最高的第一代抗精神病药

答案：A | 记忆 | P291-P293

解析：标准答案：A

101. [batch007_B1_05_Q2] 用于难治性精神分裂症，需前18周每周监测血象

答案：C | 记忆 | P291-P293

解析：标准答案：C

X型题

102. [batch007_M5_X_001] 精神分裂症阳性症状包括：

- A. 幻听（评论性或命令性言语）
- B. 被害妄想和关系妄想
- C. 思维散漫、破裂、不连贯
- D. 怪异行为和紧张症表现
- E. 情感淡漠表现

答案：ABCD | 记忆 | P73

解析：阳性症状：幻觉、妄想、思维形式障碍、行为紊乱。E情感淡漠属阴性症状。

103. [batch007_M5_X_002] 精神分裂症阴性症状包括：

- A. 情感平淡或淡漠
- B. 思维贫乏（联想数量显著减少）
- C. 意志减退和兴趣缺乏
- D. 社交退缩（回避人际交往活动）
- E. 被害妄想（坚信被议论或迫害）

答案：ABCD | 记忆 | P73

解析：阴性症状（5A）：情感平淡/淡漠、思维贫乏、意志减退、兴趣缺乏、社交退缩。E被害妄想属阳性症状。

104. [batch007_M5_X_003] 关于二代与一代抗精神病药的比较，正确的有：

- A. 二代对阴性症状改善优于一代
- B. 二代引起的EPS总体上较一代少
- C. 二代对认知症状改善有限但仍优于一代
- D. 氯氮平在二代中对难治性患者疗效最突出
- E. 所有二代药物均完全不会引起EPS

答案：ABCD | 分析 | P76, P292

解析：E错误：二代药物EPS总体较少但非为零——利培酮中高剂量EPS风险不低，阿立哌

唑也可致静坐不能。

105. [batch007_M5_X_004] 精神分裂症预后不良的因素包括：

- A. 隐袭起病，进展缓慢
- B. 阴性症状为主要表现
- C. 病前社会功能差，有家族遗传史
- D. 男性，起病年龄较早
- E. 合并物质滥用，社会支持薄弱

答案：ABCD | 记忆 | P76

解析：不良预后因素：隐袭起病、阴性症状为主、病前功能差、家族史阳性、男性、早年起病、合并物质滥用、社会支持差。以上全部为不良因素。

106. [batch007_M5_X_005] 精神分裂症认知症状的主要维度包括：

- A. 注意力的持续性和选择性损害
- B. 工作记忆和情景记忆的损害
- C. 执行功能如计划和问题解决损害
- D. 加工速度的减慢
- E. 社会认知的损害

答案：ABCD | 记忆 | P73

解析：分裂症认知症状包含注意力、记忆、执行功能、加工速度、社会认知等多维损害，是判断预后的最重要指标。

M6 抑郁障碍

A1型题

107. [batch007_M6_A1_001] 抑郁障碍核心症状（三低）包括：

- A. 思维迟缓、情绪不稳、睡眠障碍
- B. 心境低落、兴趣减退、快感缺失 ☒
- C. 焦虑紧张、恐惧不安、躯体不适
- D. 幻觉妄想、行为紊乱、情感淡漠
- E. 记忆减退、定向障碍、计算下降

答案：B | 理解 | P103

解析：抑郁障碍核心症状（三低）：心境低落、兴趣减退（快感缺失）、精力下降（疲乏

感)。D为分裂症阳性症状。

108. [batch007_M6_A1_002] 抑郁发作诊断要求症状持续至少：

- A. 1周
- B. 2周 ☒
- C. 4周
- D. 3个月
- E. 6个月

答案：B | 记忆 | P104-P105

解析：抑郁发作要求核心症状 ≥ 2 项+附加症状 ≥ 2 项，持续 ≥ 2 周，并造成社会功能损害。A（1周）为躁狂发作的诊断标准。

109. [batch007_M6_A1_003] 抑郁障碍最具特征性的睡眠障碍是：

- A. 入睡困难
- B. 早醒（比平时早醒 ≥ 2 小时） ☒
- C. 睡眠浅易醒
- D. 睡眠过多
- E. 昼夜节律紊乱

答案：B | 理解 | P104

解析：早醒（比平时早醒 ≥ 2 小时且无法再入睡）是抑郁障碍最具特征性的睡眠障碍，常伴昼夜节律紊乱（晨重暮轻）。D为非典型抑郁特征。

110. [batch007_M6_A1_004] 抑郁障碍的生物节律特征性表现为：

- A. 早晨精神饱满，晚上疲劳
- B. 晨重暮轻，早晨症状加重傍晚减轻 ☒
- C. 晨轻暮重，早晨较轻傍晚加重
- D. 午后低谷，下午两点后加重
- E. 昼夜节律完全消失无规律波动

答案：B | 理解 | P104

解析：抑郁障碍特征性表现为晨重暮轻（昼夜节律紊乱），抑郁情绪和躯体症状早晨最重，傍晚渐减轻。

111. [batch007_M6_A1_005] Beck认知理论中的负性认知三联征指：

- A. 对自我、对世界、对未来的负性看法 ☒
- B. 对过去、对现在、对将来的负性评价
- C. 对健康、对财富、对人际的负性看法
- D. 对工作、对家庭、对社会的负性评价
- E. 对思维、对情感、对行为的负性看法

答案：A | 理解 | P104

解析：Beck负性认知三联征：对自我（"我一无是处"）、对世界（"世界充满敌意"）、对未来（"将来毫无希望"）的负性看法。

112. [batch007_M6_A1_006] 抗抑郁药起效的一般时间窗为：

- A. 服药后数小时内
- B. 2至4周 ☒
- C. 1至2周
- D. 6至8周
- E. 首次服药当日

答案：B | 理解 | P107

解析：抗抑郁药一般2-4周开始起效（受体适应假说解释延迟），足量足疗程是基本原则。

113. [batch007_M6_A1_007] 抑郁障碍急性期治疗的持续时间通常为：

- A. 2至4周
- B. 8至12周 ☒
- C. 4至9个月
- D. 6个月至1年
- E. 终身服药

答案：B | 记忆 | P108

解析：三期治疗：急性期8-12周（症状缓解）、巩固期4-9月（预防复燃/原剂量）、维持期首次≥6月-1年。

114. [batch007_M6_A1_008] 难治性抑郁的定义为：

- A. 一种抗抑郁药无效即可诊断
- B. 至少两种不同机制抗抑郁药足量足疗程仍无效 ☒

- C. 任何一种药物出现副作用不能耐受
- D. 首次发作时对SSRI反应欠佳
- E. 抑郁持续超过两年未缓解

答案：B | 记忆 | P109

解析：难治性抑郁（TRD）：至少2种不同机制的抗抑郁药足量足疗程（≥6周，治疗剂量）仍无效。需排除假性难治。

115. [batch007_M6_A1_009] 抑郁伴失眠和体重减轻的患者，优先选择：

- A. 安非他酮
- B. 米氮平 ☒
- C. 氟西汀
- D. 文拉法辛
- E. 舍曲林

答案：B | 理解 | P107

解析：米氮平（NaSSA）具有镇静和增加食欲/体重的效果，特别适合伴失眠和体重减轻的患者。A适合伴疲劳/快感缺失。

116. [batch007_M6_A1_010] SSRI与MAOI联合使用的最大风险是：

- A. 增加EPS和迟发性运动障碍风险
- B. 诱发5-HT综合征，意识障碍和自主神经不稳 ☒
- C. 增加粒细胞缺乏和严重感染风险
- D. 诱发癫痫持续状态和脑电图异常
- E. 导致严重代谢综合征和体重急剧增加

答案：B | 记忆 | P299

解析：SSRI+MAOI联用可诱发5-HT综合征（意识障碍+自主神经不稳+神经肌肉异常三联征），为禁忌联用。氟西汀需5周洗脱期。

117. [batch007_M6_A1_011] 以下属于SNRI类抗抑郁药的是：

- A. 氟西汀和舍曲林
- B. 文拉法辛和度洛西汀 ☒
- C. 米氮平和安非他酮
- D. 阿米替林和氯米帕明
- E. 苯乙肼和反苯环丙胺

答案：B | 记忆 | P107

解析：SNRI（5-HT和NE再摄取抑制剂）代表药为文拉法辛和度洛西汀，双通道作用。A为SSRI，C为NaSSA/NDRI，D为TCA，E为MAOI。

118. [batch007_M6_A1_012] 抑郁症与双相抑郁鉴别的最关键点是：

- A. 抑郁发作的严重程度
- B. 既往有无躁狂或轻躁狂发作病史 ☒
- C. 发病年龄的差异
- D. 对抗抑郁药物的反应不同
- E. 家族史差异

答案：B | 理解 | P110

解析：双相与单相抑郁鉴别的核心在于有无躁狂/轻躁狂发作史。双相抑郁不能单用抗抑郁药（有转躁风险），必须以心境稳定剂为基础。

119. [batch007_M6_A1_013] PHQ-9在抑郁障碍诊疗中的用途是：

- A. 作为诊断的金标准
- B. 筛查和严重程度评估的自评工具 ☒
- C. 鉴别单相抑郁和双相障碍
- D. 评估抗抑郁药疗效的生物学指标
- E. 评估自杀风险的独立工具

答案：B | 理解 | P31

解析：PHQ-9是基于DSM-5的自评筛查工具，用于筛查和评估严重程度变化，不能替代临床诊断。

120. [batch007_M6_A1_014] 持续性抑郁障碍（心境恶劣）的诊断要求抑郁症状持续至少：

- A. 2周
- B. 2年 ☒
- C. 6个月
- D. 1年
- E. 3个月

答案：B | 记忆 | P105

解析：持续性抑郁障碍（心境恶劣）：慢性持续 ≥ 2 年（青少年 ≥ 1 年），症状较抑郁发作轻但持久。

121. [batch007_M6_A1_015] 季节性情感障碍的特征性治疗方法是：

- A. 高剂量SSRI联合二代抗精神病药
- B. 光照治疗（每日晨间亮光暴露） ☒
- C. 电抽搐治疗的表现
- D. 长期碳酸锂治疗
- E. 苯二氮䓬类长期维持

答案：B | 理解 | P104

解析：季节性情感障碍（SAD）：秋冬发作、春夏缓解，光照治疗（Bright Light Therapy）为特征性且有效的治疗方法。

122. [batch007_M6_A1_016] 抑郁障碍性别差异的正确描述是：

- A. 男性患病率约为女性两倍
- B. 女性患病率约为男性两倍 ☒
- C. 男女患病率基本相等
- D. 仅绝经期后女性患病率高
- E. 仅老年期后男性患病率高

答案：B | 理解 | P103

解析：女性抑郁障碍患病率约为男性的2倍，可能与生物学因素（激素/遗传）和社会心理因素（应激暴露差异）等多因素有关。

123. [batch007_M6_A1_017] SSRI类药物中半衰期最长的是：

- A. 氟西汀，半衰期4至6天 ☒
- B. 舍曲林，半衰期约26小时
- C. 帕罗西汀，半衰期约21小时
- D. 氟伏沙明，半衰期约15小时
- E. 西酞普兰，半衰期约35小时

答案：A | 记忆 | P107

解析：氟西汀半衰期最长（4-6天），停药需5周洗脱期才能换用MAOI。舍曲林26h，帕罗西汀21h，氟伏沙明15h，西酞普兰35h。

A2型题

124. [batch007_M6_A2_001] 患者，女，35岁，近2月情绪低落，对任何事不感兴趣，整日疲乏无力。每天凌晨3-4点醒来后无法再睡，早晨情绪最差，傍晚稍好转。体重下降5kg。无躁狂史。最可能诊断：

- A. 双相障碍抑郁发作
- B. 抑郁障碍，伴早醒和晨重暮轻 ☒
- C. 广泛性焦虑障碍
- D. 甲状腺功能减退症所致
- E. 适应障碍伴抑郁心境

答案：B | 应用 | P103-P105

解析：典型抑郁：核心症状（情绪低落+兴趣减退+疲乏）≥2项，生物症状（早醒+晨重暮轻+体重↓），持续≥2周，无躁狂史。

125. [batch007_M6_A2_002] 患者，女，28岁，诊断为中度抑郁发作，既往无用药史。首选初始治疗药物为：

- A. 舍曲林 ☒
- B. 氯氮平
- C. 苯乙肼
- D. 碳酸锂
- E. 阿米替林

答案：A | 应用 | P107

解析：首次抑郁发作首选SSRI（舍曲林/氟西汀/西酞普兰/艾司西酞普兰），安全性好、副作用可耐受。B为抗精神病药，C为MAOI，D为心境稳定剂，E为TCA。

126. [batch007_M6_A2_003] 患者，男，45岁，抑郁发作治疗后6周症状完全缓解。关于巩固期治疗正确的是：

- A. 缓解后立即停药观察
- B. 继续原剂量巩固4至9个月 ☒
- C. 将剂量减至原量的一半减少副作用
- D. 换用另一种抗抑郁药防耐受
- E. 停止药物改用单一心理治疗

答案：B | 应用 | P108

解析：巩固期：急性期缓解后继续原剂量4-9月，目标为预防复燃。过早减量/停药是复燃的最常见原因。

127. [batch007_M6_A2_004] 患者，男，52岁，抑郁发作伴全身多处疼痛（头痛、背痛、关节痛），PHQ-9评分18分。应优先选择：

- A. 氟西汀
- B. 度洛西汀 ☒
- C. 安非他酮
- D. 米氮平
- E. 曲唑酮

答案：B | 应用 | P107

解析：度洛西汀（SNRI）同时抑制5-HT和NE再摄取，NE通路参与下行疼痛抑制通路，对抑郁伴疼痛有双重改善效果。

128. [batch007_M6_A2_005] 患者，女，22岁，严重抑郁伴自杀观念，拒食拒水3天，药物治疗效果不佳。此时最适宜的措施：

- A. 增加抗抑郁药剂量等待起效
- B. MECT快速控制自杀和拒食 ☒
- C. 联合苯二氮草类缓解焦虑失眠
- D. 转诊至心理治疗中心行CBT
- E. 开始氯氮平治疗抗自杀

答案：B | 应用 | P110

解析：MECT适应证：严重自杀观念/行为、拒食/木僵、药物无效或不耐受、需快速起效。该患者严重自杀+拒食拒水，MECT是最佳选择。

129. [batch007_M6_A2_006] 患者，女，30岁，产后3周情绪低落、对婴儿缺乏兴趣、自责“不是好母亲”、入睡困难，偶有伤害婴儿的闯入性想法。以下处理不恰当的是：

- A. 开始舍曲林治疗，哺乳期相对安全
- B. 同时开展认知行为或人际心理治疗
- C. 单独使用抗精神病药作为核心治疗 ☒
- D. 认真评估自杀和伤害婴儿的风险，制定安全计划
- E. 加强家庭支持，确保母婴安全监护

答案：C | 应用 | P106

解析：围产期抑郁以SSRI（舍曲林哺乳期相对安全）+心理治疗为核心。单独使用抗精神病药非常规治疗。

130. [batch007_M6_A2_007] 患者，男，38岁，抑郁伴显著精神运动性迟滞和快感缺失，不伴失眠和体重减轻。应优先选择：

- A. 氟西汀 ☒
- B. 帕罗西汀
- C. 米氮平
- D. 安非他酮
- E. 阿米替林

答案：A | 应用 | P107

解析：氟西汀激活性强，适合迟滞型抑郁。B帕罗西汀镇静强适合焦虑型；C米氮平适合伴失眠体重↓；D安非他酮对快感缺失也有效但激活性不如氟西汀；E TCA副作用多过量危险。

病例

患者，女，35岁。近2月情绪低落、对任何事情不感兴趣、疲乏无力。每天凌晨3-4点醒来后无法再睡，早晨情绪最差。体重下降5kg。HAMD-17评分24分。患者承认"活着没意思"，但否认具体自杀计划。

131. [batch007_v3_EXT_A3_002_Q1] 该患者应考虑的诊断是：

- A. 双相障碍抑郁发作
- B. 适应障碍伴抑郁心境
- C. 重性抑郁障碍伴忧郁特征 ☒
- D. 持续性抑郁障碍心境恶劣
- E. 甲状腺功能减退所致抑郁

答案：C | 应用

解析：核心症状（情绪低落+兴趣减退+疲乏）≥2项，伴忧郁特征（早醒+晨重暮轻+体重显著下降），HAMD-17=24分（中度），持续2月>2周，无躁狂史→重性抑郁障碍伴忧郁特征。D需≥2年；B病程不符。

132. [batch007_v3_EXT_A3_002_Q2] 评估该患者自杀风险时，最关键的问题是：

- A. 既往是否有过抑郁发作
- B. 有无具体自杀计划手段和时间安排 ☒
- C. 最近一周的睡眠总时长
- D. 体重下降的确切公斤数
- E. 是否对药物过敏

答案：B | 应用

解析：患者已表达“活着没意思”（被动自杀观念），最关键的是评估有无主动自杀计划、具体手段（如蓄药/买刀）、时间安排。有具体计划者自杀完成风险急剧升高。A/E为常规病史，C/D为症状严重度评估。

133. [batch007_v3_EXT_A3_002_Q3] 若评估自杀风险为中度，首选治疗方案是：

- A. SSRI联合认知行为治疗 ☒
- B. 单用苯二氮䓬类药物
- C. 立即行改良电抽搐治疗MECT
- D. 心境稳定剂联合抗精神病药
- E. 仅予支持性心理治疗

答案：A | 应用

解析：中度抑郁伴中度自杀风险，首选SSRI（如舍曲林/艾司西酞普兰）联合心理治疗（CBT/IPT）。C MECT适用于严重自杀企图/拒食/木僵/药物无效者（本例为中度风险且无具体计划）。B无抗抑郁作用；D用于双相。

134. [batch007_v3_EXT_A3_002_Q4] 治疗2周后患者突然变得兴奋话多、精力旺盛，此时应首先考虑：

- A. 抗抑郁药起效的正常反应
- B. 转相为躁狂发作需排查双相障碍 ☒
- C. 药物过敏导致的兴奋激越
- D. 5-HT综合征的早期表现
- E. 撤药综合征的临床表现

答案：B | 应用

解析：抗抑郁药治疗中出现兴奋话多/精力旺盛→应高度警惕转相（抗抑郁药诱发躁狂/轻躁狂），需排查双相障碍可能。此时应停用抗抑郁药，评估是否需诊断修正为双相障碍，启用锂盐等心境稳定剂。A非正常反应；D表现为意识障碍+肌阵挛。

共用选项

- A. SSRI
- B. SNRI
- C. NaSSA
- D. NDRI
- E. TCA

135. [batch007_B1_06_Q1] 氟西汀、舍曲林、帕罗西汀、西酞普兰所属抗抑郁药类别

答案：A | 记忆 | P298

解析：标准答案：A

136. [batch007_B1_06_Q2] 文拉法辛、度洛西汀所属抗抑郁药类别

答案：B | 记忆 | P298

解析：标准答案：B

X型题

137. [batch007_M6_X_001] 抑郁障碍心理症状群包括：

- A. 思维迟缓（联想速度减慢）
- B. 负性认知三联征
- C. 自责自罪观念，严重可为罪恶妄想
- D. 自杀观念和行为
- E. 注意力和记忆力损害

答案：ABCD | 记忆 | P104

解析：心理症状群：思维迟缓+负性认知三联征+自责自罪+自杀观念行为+认知功能损害。
以上全属心理症状群。

138. [batch007_M6_X_002] 关于5-HT综合征的临床表现，正确的有：

- A. 意识障碍包括意识模糊甚至昏迷
- B. 自主神经不稳如发热出汗血压波动
- C. 神经肌肉异常如肌阵挛腱反射亢进震颤
- D. 最常见诱因因为SSRI与MAOI禁忌联用
- E. 治疗关键是立即停用所有5-HT能药物并支持治疗

答案：ABCD | 理解 | P299

解析：5-HT综合征三联征：意识障碍+自主神经不稳+神经肌肉异常。最常见诱因SSRI+MAOI联用。治疗：停药+支持。以上全部正确。

139. [batch007_M6_X_003] 抑郁与双相鉴别时，支持双相障碍的线索包括：

- A. 发病年龄较早，通常25岁前首次发作

- B. 既往有明确的躁狂或轻躁狂发作史
- C. 双相障碍阳性家族遗传史
- D. 使用抗抑郁药后出现过转躁反应
- E. 抑郁发作频繁，次数超过四次

答案：ABCD | 分析 | P110

解析：双相抑郁线索：早年起病（<25岁）、躁狂/轻躁狂史、双相家族史、抗抑郁药诱发转躁、频繁复发。以上均支持双相诊断。

140. [batch007_M6_X_004] 抑郁障碍躯体症状群包括：

- A. 睡眠障碍，早醒最具特征
- B. 食欲减退和体重下降
- C. 精力下降和疲乏无力
- D. 性欲减退（兴趣和欲望下降）
- E. 昼夜节律紊乱，晨重暮轻

答案：ABCD | 记忆 | P104

解析：躯体症状群（生物症状）：睡眠障碍（早醒）、食欲/体重↓、精力↓、性欲↓、昼夜节律（晨重暮轻）。以上全属躯体症状群。

141. [batch007_M6_X_005] 抑郁障碍治疗分期及各期目标匹配正确的有：

- A. 急性期8-12周，目标为症状缓解
- B. 巩固期4-9月，目标为预防复燃，维持原剂量
- C. 维持期首次≥6月-1年，目标为预防复发
- D. 复发者维持期≥2-3年或更长
- E. 急性期缓解后即可停药观察

答案：ABCD | 理解 | P103-P108

解析：E错误：急性期缓解后不可立即停药，需进入巩固期（原剂量4-9月）。其余分期和目标均正确。

M7 双相及相关障碍

A1型题

142. [batch007_M7_A1_001] 躁狂发作的核心症状（三高）包括：

- A. 幻觉、妄想、行为紊乱

- B. 情感高涨、思维奔逸、活动增多 ☒
- C. 焦虑、紧张、失眠
- D. 记忆减退、注意涣散、定向障碍
- E. 强迫思维、强迫行为、过度洗涤

答案：B | 理解 | P95

解析：躁狂发作核心症状（三高）：情感高涨（或易激惹）、思维奔逸（联想加速/话题转换）、活动增多（精力旺盛/行为增多）。

143. [batch007_M7_A1_002] 轻躁狂发作的最低持续时间要求是：

- A. 2天
- B. 4天 ☒
- C. 1周
- D. 2周
- E. 1个月

答案：B | 记忆 | P96

解析：轻躁狂：持续 ≥ 4 天，社会功能轻度受损，无精神病性症状。躁狂：持续 ≥ 1 周（或需住院），严重功能损害，可伴精神病性症状。

144. [batch007_M7_A1_003] 双相I型与双相II型的核心区别在于：

- A. I型必须有抑郁发作，II型不需要
- B. I型至少有一次躁狂发作，II型仅有轻躁狂 ☒
- C. I型遗传度更高，II型更与环境有关
- D. I型对锂盐反应好，II型对锂盐反应差
- E. I型女性更常见，II型男性更常见

答案：B | 理解 | P97

解析：双相I型：至少1次躁狂发作（抑郁可有可无）。双相II型：至少1次轻躁狂+至少1次抑郁发作，从未有过躁狂发作。

145. [batch007_M7_A1_004] 碳酸锂治疗窗的有效浓度范围是：

- A. 0.2至0.4 mmol/L
- B. 0.6至1.2 mmol/L ☒
- C. 1.5至2.0 mmol/L
- D. 0.1至0.3 mmol/L

- E. 2.0至2.8 mmol/L

答案：B | 记忆 | P301

解析：锂盐治疗窗0.6-1.2mmol/L，需定期监测血锂浓度。中毒浓度>1.4mmol/L，早期中毒信号：粗大震颤、意识障碍。

146. [batch007_M7_A1_005] 快速循环型双相障碍的定义是：

- A. 一年内发作至少2次
- B. 一年内心境发作≥4次 ☒
- C. 一年内躁狂发作≥3次
- D. 一年内抑郁发作≥3次
- E. 一年内混合发作≥2次

答案：B | 记忆 | P97

解析：快速循环型：1年内≥4次心境发作（躁狂/轻躁狂/抑郁/混合），对锂盐反应可能较差，丙戊酸钠常为首选。

147. [batch007_M7_A1_006] 丙戊酸钠相对于锂盐的优势在于：

- A. 在所有方面均完全优于锂盐
- B. 对快速循环型和混合发作疗效优于锂盐 ☒
- C. 完全没有副作用
- D. 维持治疗预防效果优于锂盐
- E. 妊娠期安全性等同于锂盐

答案：B | 记忆 | P98

解析：丙戊酸钠对快速循环型和混合发作优于锂盐，但有致畸性（妊娠期禁忌）。锂盐在维持治疗中仍为经典首选。

148. [batch007_M7_A1_007] 双相障碍抑郁发作时抗抑郁药的使用原则是：

- A. 可单独使用抗抑郁药治疗
- B. 心境稳定剂基础上谨慎使用，密切监测转躁风险 ☒
- C. 抗抑郁药应作为一线首选
- D. 治疗药物选择与单相抑郁基本一致
- E. 相对禁止使用任何抗抑郁药

答案：B | 理解 | P95

解析：绝不单用抗抑郁药治疗双相抑郁（转躁风险）。必须在心境稳定剂基础上谨慎使用，倾向转躁风险较低的药物（安非他酮/SSRI）。

149. [batch007_M7_A1_008] 拉莫三嗪在双相障碍治疗中的突出优势是：

- A. 对急性躁狂有快速强效控制作用
- B. 对抑郁相的预防效果优于对躁狂相的预防 ✓
- C. 疗效与氯氮平相当
- D. 可单药治疗急性躁狂发作
- E. 妊娠期安全性在所有心境稳定剂中最高

答案：B | 记忆 | P98

解析：拉莫三嗪对双相抑郁的预防效果好（抑郁相>躁狂相），但对急性躁狂效果有限。需缓慢加量以降低Stevens-Johnson综合征风险。

150. [batch007_M7_A1_009] 锂盐中毒的早期信号不包括：

- A. 粗大震颤
- B. 意识障碍如嗜睡和意识模糊
- C. 恶心呕吐和腹泻
- D. 共济失调步态不稳和构音障碍
- E. 情绪稳定思维清晰的正常精神状态 ✓

答案：E | 理解 | P301

解析：锂盐中毒信号：粗大震颤+意识障碍+恶心呕吐+共济失调。E为正常状态，非中毒表现（反选题中的阴性选项）。

151. [batch007_M7_A1_010] 混合发作的正确描述是：

- A. 躁狂和抑郁症状交替出现持续数天
- B. 躁狂和抑郁症状同时存在，持续≥2周 ✓
- C. 仅见于双相I型
- D. 治疗方案与单纯躁狂基本一致
- E. 不需心境稳定剂仅用抗精神病药

答案：B | 理解 | P97

解析：混合发作：躁狂和抑郁症状同时存在（非交替），持续≥2周。治疗以心境稳定剂（丙戊酸钠优于锂盐）+二代抗精神病药为主。

152. [batch007_M7_A1_011] 奥氮平治疗急性躁狂的疗效比较结论是：

- A. 疗效显著优于所有心境稳定剂
- B. 疗效与锂盐、丙戊酸钠、氟哌啶醇疗效相当 ☒
- C. 对躁狂完全无效仅对抑郁有效
- D. 疗效明显不如传统抗精神病药
- E. 只能作为联合用药不能单药治疗

答案：B | 记忆 | P95

解析：奥氮平治疗急性躁狂疗效与锂盐、丙戊酸钠、氟哌啶醇疗效相当（非优效），优于安慰剂。

153. [batch007_M7_A1_012] 急性躁狂发作的标准联合治疗方案为：

- A. 单用抗抑郁药逐渐加量
- B. 心境稳定剂联合二代抗精神病药控制兴奋 ☒
- C. 单用苯二氮䓬类作为核心治疗
- D. 抗抑郁药联合抗精神病药一线治疗
- E. 仅予心理治疗暂不使用药物

答案：B | 理解 | P95

解析：急性躁狂标准方案：心境稳定剂（锂盐/丙戊酸钠）+二代抗精神病药（奥氮平/利培酮/喹硫平等）联合，快速控制兴奋。

154. [batch007_M7_A1_013] 环性心境障碍的诊断要求心境不稳持续至少：

- A. 6个月
- B. 1年
- C. 2年 ☒
- D. 3年
- E. 6周

答案：C | 记忆 | P97

解析：环性心境障碍：反复心境不稳（轻躁狂+轻度抑郁）持续≥2年（青少年≥1年），但从未达到躁狂或抑郁发作的完全诊断标准。

155. [batch007_M7_A2_001] 患者，男，28岁，近1周异常兴奋、话多且话题不断转换，称“我是天才，身价百亿”，晚上只睡2-3小时却精力充沛，花钱大手大脚。精神检查：情绪高涨、思维奔逸、夸大妄想。最可能诊断：

- A. 精神分裂症偏执型
- B. 双相I型障碍，躁狂发作伴精神病性症状 ☒
- C. 轻躁狂发作
- D. 环性心境障碍的表现
- E. 急性短暂性精神病性障碍

答案：B | 应用 | P95-P97

解析：典型躁狂：持续≥1周，情感高涨+思维奔逸+活动增多+夸大妄想+睡眠需求↓+功能严重受损，符合双相I型躁狂发作。

156. [batch007_M7_A2_002] 患者，女，32岁，反复情绪异常5年。曾多次话多兴奋、精力旺盛、睡眠减少但不疲倦，持续约1周。近2月情绪低落、兴趣减退。既往从未达躁狂诊断标准。最可能诊断：

- A. 双相I型障碍
- B. 双相II型障碍 ☒
- C. 复发性抑郁障碍
- D. 环性心境障碍
- E. 边缘性人格障碍

答案：B | 应用 | P97

解析：有轻躁狂发作（话多/精力旺盛/睡眠↓约1周）但未达躁狂标准+目前抑郁发作+从无躁狂史→双相II型。

157. [batch007_M7_A2_003] 患者，男，25岁，确诊双相I型，目前抑郁发作。既往曾单用氟西汀后出现转躁。该患者抑郁发作最佳方案：

- A. 单用舍曲林治疗的表现
- B. 碳酸锂加谨慎使用安非他酮，密切监测转躁 ☒
- C. 单用奥氮平治疗的表现
- D. 丙戊酸钠联合氟西汀治疗
- E. 停止所有药物仅行认知行为治疗

答案：B | 应用 | P95

解析：双相抑郁：心境稳定剂为基础（锂盐首选）+谨慎使用抗抑郁药（安非他酮转躁风险较低），严密监测。该患者有SSRI转躁史，应避免再次使用。

158. [batch007_M7_A2_004] 患者，女，40岁，双相I型维持治疗服碳酸锂。血锂1.5mmol/L，近1周双手粗大震颤、步态不稳、恶心呕吐、嗜睡。首选处理：

- A. 继续原剂量，加用普萘洛尔控制震颤
- B. 立即停用碳酸锂，检测血锂，补液支持治疗 ☒
- C. 将剂量减半继续服用，三天后复查
- D. 维持不变，加用抗精神病药控制症状
- E. 立即换用丙戊酸钠替代

答案：B | 应用 | P301

解析：血锂1.5>1.4mmol/L（中毒浓度），伴典型中毒症状（粗大震颤+共济失调+恶心呕吐+嗜睡），立即停药、检测血锂、补液加速排泄。严重中毒需血液透析。

159. [batch007_M7_A2_005] 患者，女，28岁，双相障碍，妊娠8周，目前服用丙戊酸钠维持。精神科最恰当建议：

- A. 继续丙戊酸钠，其心境稳定效果最可靠
- B. 与产科协商，权衡利弊考虑换用锂盐或非药物治疗 ☒
- C. 增加丙戊酸钠剂量防妊娠期复发
- D. 立即停药，妊娠期全程不用任何药物
- E. 换用卡马西平，妊娠期安全性更高

答案：B | 应用 | P100

解析：丙戊酸钠致畸性明确（神经管缺陷），妊娠期应避免。需与产科协商，可考虑换用锂盐（权衡心脏畸形风险）或非药物干预。卡马西平同样有致畸性。

160. [batch007_M7_A2_006] 患者，女，34岁，双相II型，目前为抑郁发作。以下药物选择不恰当的是：

- A. 锂盐基础上加用安非他酮
- B. 拉莫三嗪基础上加用舍曲林
- C. 单用氟西汀40mg/d治疗 ☒
- D. 喹硫平单药治疗抑郁
- E. 锂盐联合拉莫三嗪

答案：C | 应用 | P95

解析：双相抑郁严禁单用抗抑郁药（有转躁风险）。C单用氟西汀违反治疗原则。A/B心境稳定剂基础上谨慎加用抗抑郁药可接受；D喹硫平有抗抑郁效果；E双心境稳定剂联合可接受。

病例

患者，男，28岁。近1周异常兴奋、话多话题不断转换、称"身价百亿"、每晚只睡2-3小时却精力充沛、挥霍无度。既往曾有类似但较轻的发作。精神检查：情绪高涨、思维奔逸、夸大妄想。

161. [batch007_v3_EXT_A3_003_Q1] 该患者最可能的诊断是：

- A. 精神分裂症偏执型
- B. 双相I型障碍躁狂发作 ☒
- C. 双相II型障碍轻躁狂发作
- D. 环性心境障碍
- E. 分裂情感性障碍

答案：B | 应用

解析：核心三高（情感高涨+思维奔逸+活动增多）+夸大妄想（精神病性症状）+睡眠需求↓+功能严重受损+持续≥1周→双相I型躁狂发作。C轻躁狂无精神病性症状且功能轻度受损；D需≥2年。

162. [batch007_v3_EXT_A3_003_Q2] 该患者急性期首选的心境稳定剂是：

- A. 碳酸锂或丙戊酸钠 ☒
- B. 拉莫三嗪单药治疗
- C. 苯二氮䓬类单药治疗
- D. SSRI类抗抑郁药
- E. 卡马西平单药治疗

答案：A | 应用

解析：急性躁狂首选心境稳定剂碳酸锂（经典首选）或丙戊酸钠（尤其快速循环/混合发作），常联合二代抗精神病药（奥氮平/利培酮/喹硫平）快速控制兴奋。B对躁狂急性期效果有限（以抑郁预防见长）；D禁单用于双相。

163. [batch007_v3_EXT_A3_003_Q3] 若选用碳酸锂，必须定期监测的指标是：

- A. 仅监测血常规即可
- B. 血锂浓度和甲状腺功能及肾功能 ☒
- C. 仅监测肝功能即可
- D. 仅监测心电图QTc间期
- E. 仅监测体重和腰围变化

答案：B | 应用

解析：锂盐三大监测：①血锂浓度（治疗窗0.6-1.2mmol/L，>1.4中毒）；②甲状腺功能（甲减风险）；③肾功能（血肌酐/尿常规/尿比重，长期肾损害风险）。心电图、体重为辅助监测。

164. [batch007_v3_EXT_A3_003_Q4] 联合奥氮平治疗1周后，患者出现高热39.5°C、意识模糊、全身肌强直，应首先考虑：

- A. 感染性发热给予抗生素治疗
- B. 恶性综合征需立即停药并支持治疗 ☒
- C. 锂盐中毒减量继续观察
- D. 5-HT综合征更换抗抑郁药
- E. 药物过敏反应给予抗组胺药

答案：B | 应用

解析：抗精神病药治疗后出现高热+肌强直+意识障碍→恶性综合征（NMS）。需立即停用所有抗精神病药，支持治疗（降温/补液/监护），必要时丹曲林/溴隐亭。C锂盐中毒表现为粗大震颤而非肌强直；D有5-HT能药物使用史。

共用选项

- A. 碳酸锂
- B. 丙戊酸钠
- C. 卡马西平
- D. 拉莫三嗪
- E. 奥氮平

165. [batch007_B1_07_Q1] 经典心境稳定剂，治疗窗0.6-1.2mmol/L，需监测血锂浓度

答案：A | 记忆 | P98, P301

解析：标准答案：A

166. [batch007_B1_07_Q2] 对快速循环型和混合发作疗效优于锂盐，但有致畸性

答案：B | 记忆 | P98, P301

解析：标准答案：B

X型题

167. [batch007_M7_X_001] 躁狂发作的伴随症状（DSM-5需≥3项）包括：

- A. 夸大观念和夸大妄想
- B. 睡眠需求显著减少但次日精力充沛
- C. 注意力随境转移，易被外界分散
- D. 挥霍无度，行为不计后果
- E. 性欲亢进，行为轻率不顾社会规范

答案：ABCD | 记忆 | P95-P96

解析：躁狂7项伴随症状（需≥3项，如为易激惹则需≥4项）：夸大、睡眠需求↓、多语、思维奔逸、随境转移、活动增多、冒险行为。以上全部为伴随症状。

168. [batch007_M7_X_002] 以下属于心境稳定剂的药物有：

- A. 心境稳定剂碳酸锂
- B. 丙戊酸钠
- C. 卡马西平
- D. 拉莫三嗪
- E. 奥氮平和喹硫平

答案：ABCD | 记忆 | P98

解析：心境稳定剂：锂盐（经典首选）、丙戊酸钠、卡马西平、拉莫三嗪，部分二代抗精神病药（奥氮平/喹硫平/利培酮/阿立哌唑）也具心境稳定作用。

169. [batch007_M7_X_003] 锂盐的常见不良反应包括：

- A. 细震颤和手抖
- B. 多尿和烦渴
- C. 甲状腺功能减退
- D. 体重增加和水肿
- E. 肾功能损害需长期监测

答案：ABCD | 记忆 | P301

解析：锂盐常见不良反应：神经系统（细震颤/认知迟钝）、肾脏（多尿/烦渴/肾浓缩↓/长期肾损害）、甲状腺（甲减）、体重增加/水肿。需定期监测血锂、甲功、肾功。

170. [batch007_M7_X_004] 导致锂盐中毒的诱因包括：

- A. 肾清除率降低如使用利尿剂或脱水

- B. 钠摄入显著减少
- C. 锂盐过量摄入
- D. 年老体弱肾功能储备下降
- E. 血锂浓度控制不当

答案：ABCD | 记忆 | P301

解析：锂盐中毒诱因：肾清除率↓（利尿剂/脱水/肾衰）、钠摄入↓、过量、年老体弱、血锂控制不当。以上全部为中毒诱因。

171. [batch007_M7_X_005] 双相障碍与精神分裂症鉴别时支持双相障碍的线索包括：

- A. 以情感症状为主导，心境极度波动
- B. 幻觉妄想内容与心境协调（夸大/被害）
- C. 发作性病程，间歇期功能恢复良好
- D. 以思维障碍为核心，情感淡漠突出
- E. 有明确的躁狂或轻躁狂发作病史

答案：ABCE | 理解 | P99-P100

解析：D以思维障碍为核心和情感淡漠为分裂症特征。双相特征：情感症状主导+心境协调妄想+发作性+间歇期良好+躁狂/轻躁狂史。

M8 强迫及相关障碍

A1型题

172. [batch007_M8_A1_001] 强迫症的诊断要求强迫思维或行为每日耗时至少：

- A. 30分钟
- B. 1小时 ☒
- C. 15分钟
- D. 2小时
- E. 3小时

答案：B | 记忆 | P124

解析：强迫症诊断要求强迫思维/行为耗时≥1小时/天，且引起显著痛苦或社会功能损害。患者自知力存在。

173. [batch007_M8_A1_002] 强迫症药物治疗的首选类别是：

- A. 苯二氮䓬类

- B. SSRI类 ☒
- C. 第一代抗精神病药
- D. 心境稳定剂
- E. 中枢兴奋剂

答案：B | 记忆 | P128

解析：SSRI为强迫症一线药物（有效65-70%），需高剂量（高于抑郁治疗剂量）+长疗程。氯米帕明疗效好但副作用多，常为二线。

174. [batch007_M8_A1_003] 躯体变形障碍的临床表现核心是：

- A. 持续关注体重变化伴进食行为问题
- B. 坚信自己外貌存在缺陷，他人能注意到的先占观念 ☒
- C. 反复拔除毛发造成显著毛发缺失
- D. 反复搔抓皮肤造成损伤但不能停止
- E. 坚信患严重躯体疾病，检查阴性不能消除疑虑

答案：B | 理解 | P130

解析：躯体变形障碍（BDD）：坚信外貌有缺陷，先占观念，反复照镜或回避。SSRI为一
线治疗（高剂量长疗程）。E为疑病障碍核心表现。

175. [batch007_M8_A1_004] 强迫思维的核心特征不包括：

- A. 闯入性，不由自主地出现
- B. 重复性，反复出现难以摆脱
- C. 不受欢迎，患者试图抵抗
- D. 思维插入，外部力量强行植入脑内 ☒
- E. 引起显著焦虑和痛苦

答案：D | 理解 | P124-P125

解析：D思维插入是Schneider一级症状（精神分裂症被动体验），非强迫思维特征。强迫思维特征：闯入性、重复性、不受欢迎、引起焦虑、被试图抵抗。

176. [batch007_M8_A1_005] 氯米帕明治疗强迫症的特点为：

- A. 疗效优于SSRI且副作用较少
- B. 非选择性SRI，疗效好但副作用多，常为二线或联合用药 ☒
- C. 属于SSRI类，强迫症一线首选
- D. 主要用于儿童强迫症，成人禁用

- E. 仅对强迫行为有效，对强迫思维无效

答案：B | 记忆 | P128

解析：氯米帕明为TCA类非选择性SRI，对强迫症疗效好但抗胆碱副作用多（口干/便秘/嗜睡/体重↑），常作为SSRI无效后的二线或联合用药。

A2型题

177. [batch007_M8_A2_001] 患者，男，28岁，近5年反复"怕脏"，每天洗澡洗手>3小时，反复检查门窗，明知不必要但无法控制。手部皮肤因反复清洗破裂。最合适初始治疗：

- A. 氟西汀60mg/d联合CBT ☒
- B. 氟哌啶醇从低剂量加量
- C. 氯硝西泮长期维持
- D. 电抽搐治疗快速控制
- E. 单用心理分析治疗

答案：A | 应用 | P128

解析：强迫症一线：SSRI高剂量（氟西汀60-80mg/d）+CBT（暴露与反应预防ERP）。典型症状：怕脏+反复清洗+反复检查。

178. [batch007_M8_A2_002] 难治性强迫症（SSRI足量足疗程无效）的增效策略是：

- A. 立即停用SSRI换用苯二氮䓬类
- B. SSRI基础上联合小剂量非典型抗精神病药 ☒
- C. 单用CBT停止所有药物
- D. 换用一代抗精神病药为核心
- E. 联合苯二氮䓬类长期维持

答案：B | 应用 | P128

解析：难治性强迫症增效策略：SSRI基础上联合小剂量非典型抗精神病药（利培酮/阿立哌唑/喹硫平），可增强抗强迫疗效。

X型题

179. [batch007_M8_X_001] 常见强迫症状类型包括：

- A. 怕污染反复洗涤清洁
- B. 反复怀疑反复检查
- C. 追求对称排序强迫摆放

- D. 攻击性和性内容强迫思维
- E. 宗教内容强迫思维和道德顾虑

答案：ABCD | 记忆 | P125-P126

解析：常见强迫症状维度：污染/洗涤、怀疑/检查、对称/排序/计数、攻击/伤害、性/宗教等。以上均为DSM-5描述的常见类型。

M9 躯体忧虑障碍及疑病障碍

A1型题

180. [batch007_M9_A1_001] 躯体忧虑障碍的诊断要求症状持续至少：

- A. 2周
- B. 6个月 ☒
- C. 1个月
- D. 3个月
- E. 1年

答案：B | 记忆 | P162

解析：躯体忧虑障碍要求躯体症状持续≥6月，对症状的过度思维/感受/行为，且非故意伪装。

181. [batch007_M9_A1_002] 躯体忧虑障碍与疑病障碍的核心鉴别点：

- A. 躯体忧虑多见于女性，疑病多见于男性
- B. 躯体忧虑关注已有症状，疑病恐惧患上疾病 ☒
- C. 躯体忧虑对SSRI有效，疑病对SSRI无效
- D. 躯体忧虑症状固定，疑病症状不断变化
- E. 躯体忧虑发病较早，疑病发病较晚

答案：B | 理解 | P168

解析：核心鉴别：躯体忧虑障碍=对已有躯体症状过度关注；疑病障碍=恐惧患上严重疾病（健康焦虑）。两者均对SSRI+CBT有效。

182. [batch007_M9_A1_003] 躯体忧虑障碍核心特征不包括：

- A. 对躯体症状的过度思考和反复关注
- B. 对躯体症状的过度感受和情绪反应
- C. 过度行为如反复就医和检查

- D. 故意伪装或编造躯体症状以获取利益 ☒
- E. 检查阴性仍持续关注躯体症状

答案：D | 理解 | P162-P163

解析：躯体忧虑障碍核心：对症状的过度思维/感受/行为（三维），非故意伪装。D为做作性障碍/诈病特征。

183. [batch007_M9_A1_004] 躯体忧虑障碍和疑病障碍的共同治疗原则：

- A. 以抗精神病药为核心长期维持
- B. SSRI/SNRI联合CBT，避免不必要的重复检查 ☒
- C. 苯二氮䓬类长期维持定期随访
- D. 电抽搐治疗为一线并辅以心理教育
- E. 抗癫痫药为核心并生物反馈治疗

答案：B | 理解 | P170

解析：共同治疗原则：SSRI/SNRI+CBT，避免不必要的反复检查（反复检查强化患者疾病信念）。良好医患关系是治疗基础。

184. [batch007_M9_A1_005] 疑病障碍的核心特征是：

- A. 对已有躯体症状的过度关注和反复就医
- B. 坚信或恐惧自己患有严重疾病，检查阴性不能消除疑虑 ☒
- C. 故意伪装躯体症状以获取外部利益
- D. 多种躯体症状持续超过六个月
- E. 发作性强烈恐惧伴心悸胸闷等躯体症状

答案：B | 记忆 | P168-P170

解析：疑病障碍核心：坚信/恐惧患有严重疾病（健康焦虑），检查阴性不能消除。A为躯体忧虑障碍；C为诈病或做作性障碍；D为躯体忧虑障碍病程；E为惊恐障碍。

185. [batch007_M9_A1_006] 惊恐障碍与躯体忧虑障碍的躯体症状鉴别要点：

- A. 两者躯体症状表现基本一致无法区分
- B. 惊恐障碍为发作性伴强烈恐惧，躯体忧虑障碍为持续性伴过度关注 ☒
- C. 惊恐障碍躯体症状更轻微
- D. 躯体忧虑障碍的躯体症状为发作性
- E. 惊恐障碍的躯体症状持续数年

答案：B | 理解 | P175

解析：核心鉴别：惊恐障碍=发作性（数分钟达峰，<1小时）+强烈恐惧+躯体症状；躯体忧虑障碍=持续性（≥6月）+过度关注已有症状+反复就医。

A2型题

186. [batch007_M9_A2_001] 患者，男，40岁，近8月反复因"心慌胸闷胃痛头痛"在多家医院就诊，多次心电图胃镜头颅CT均未见异常，仍坚持"身体一定出了大问题"，反复要求进一步检查。最可能诊断：

- A. 疑病障碍
- B. 躯体忧虑障碍 ☒
- C. 惊恐障碍
- D. 广泛性焦虑障碍
- E. 转换障碍

答案：B | 应用 | P162-P163

解析：多种躯体症状（心慌/胸闷/胃痛/头痛）+对症状过度关注（反复就医）+持续≥6月（8月）+检查阴性未消除疑虑→躯体忧虑障碍。

X型题

187. [batch007_M9_X_001] 躯体忧虑障碍的特征包括：

- A. 症状可涉及消化心血管神经等多系统
- B. 对躯体症状过度关注持续≥6月
- C. 反复就医接受不必要的检查
- D. 阴性结果仍不能消除患者疑虑
- E. 需与GAD和惊恐障碍等鉴别

答案：ABCD | 记忆 | P162-P163

解析：躯体忧虑障碍特征：多系统症状+持续≥6月+反复就医+阴性不能消除疑虑+需与GAD/惊恐/疑病鉴别。以上全部正确。

M10 应激相关障碍

A1型题

188. [batch007_M10_A1_001] 应激相关障碍的共同特征是：

- A. 所有均与遗传因素有明确因果关系
- B. 与应激源存在明显因果关系，应激源消除后症状常改善 ☒
- C. 所有症状持续时间均超过六个月
- D. 所有均需抗精神病药作为核心治疗
- E. 所有均表现为精神病性症状障碍

答案：B | 理解 | P134

解析：应激相关障碍共同特征：应激源与疾病之间存在明显因果关系（时间密切相关），应激源消除后症状常逐渐改善。

189. [batch007_M10_A1_002] 急性应激障碍症状持续时间要求为：

- A. 创伤后立即发生，3天至1个月 ☒
- B. 创伤后立即发生，必须超过1个月
- C. 创伤后数周起病，持续超过3个月
- D. 创伤后立即发生，仅持续数小时
- E. 创伤后立即发生，持续至少6个月

答案：A | 记忆 | P136

解析：急性应激障碍：创伤后立即发生（数分钟-数天），持续3天至1月。若症状超1月则考虑PTSD诊断。1月为关键时间分界。

190. [batch007_M10_A1_003] PTSD的诊断要求症状持续至少：

- A. 1周
- B. 1个月 ☒
- C. 2周
- D. 3个月
- E. 6个月

答案：B | 记忆 | P135-P136

解析：PTSD诊断要求：创伤事件+闯入+回避+认知情绪负性改变+警觉增高，所有症状持续>1月，造成显著功能损害。<1月为急性应激障碍。

191. [batch007_M10_A1_004] PTSD闯入性症状不包括：

- A. 闪回，创伤事件反复在脑中逼真再现
- B. 反复出现与创伤相关的噩梦
- C. 闯入性创伤回忆无法自控反复出现

- D. 回避与创伤相关的刺激情景和人物 ☒
- E. 接触创伤线索时出现强烈心理生理痛苦

答案：D | 理解 | P135-P136

解析：PTSD五大症状群：闯入（A/B/C/E）、回避、认知情绪负性改变、警觉增高。D属回避症状群，不属闯入性症状。

192. [batch007_M10_A1_005] 适应障碍的病程特点是：

- A. 应激后立即起病，持续终生不可缓解
- B. 应激后1-3月内起病，应激源消除后6个月内缓解 ☒
- C. 应激后立即起病，持续一年后才缓解
- D. 无明确应激源，隐袭起病进行性加重
- E. 起病急骤，每次仅持续数天即可缓解

答案：B | 理解 | P139

解析：适应障碍：应激源后1-3月起病，症状在应激源消除后≤6月缓解。核心为对应激源的不适应反应，未达其他精神障碍诊断标准。

193. [batch007_M10_A1_006] PTSD最被推荐的循证心理治疗是：

- A. 精神分析治疗和自由联想
- B. CBT尤其是延长暴露和EMDR ☒
- C. 系统脱敏和生物反馈
- D. 人本主义治疗
- E. 催眠治疗和暗示

答案：B | 理解 | P140

解析：PTSD循证心理治疗：CBT（以创伤为焦点的CBT，延长暴露疗法）和EMDR（眼动脱敏与再加工）最为推荐。SSRI可辅助。避免过早心理干预。

194. [batch007_M10_A1_007] PTSD的易感因素中不包括以下哪项：

- A. 既往存在焦虑或抑郁障碍病史
- B. 高智商和高社会经济地位 ☒
- C. 女性性别
- D. 既往创伤史
- E. 神经质人格特征

答案：B | 记忆 | P135

解析：B高智商和高社会经济地位是PTSD的保护因素而非易感因素。易感因素包括：焦虑/抑郁史+女性+既往创伤史+低智商+神经质+缺乏社会支持。

195. [batch007_M10_A1_008] PTSD应激源的类型不包括以下哪项：

- A. 战争经历和恐怖袭击事件
- B. 自然灾害如地震和洪水
- C. 日常工作中的一般压力情境 ☒
- D. 性暴力和躯体虐待
- E. 严重交通事故和丧失亲人

答案：C | 理解 | P135

解析：PTSD应激源为创伤性事件（危及生命/严重伤害/性暴力），C日常一般压力不符合创伤性事件标准。A/B/D/E均为典型PTSD应激源。

A2型题

196. [batch007_M10_A2_001] 患者，女，25岁，2月前经历严重车祸（目睹同伴死亡）。近1月反复闪回噩梦、不敢坐车、回避相关谈话、易激惹、高度警惕。最可能诊断：

- A. 急性应激障碍
- B. PTSD ☒
- C. 适应障碍
- D. 广泛性焦虑障碍
- E. 重度抑郁发作

答案：B | 应用 | P135-P136

解析：创伤事件（车祸/目睹死亡）+闯入（闪回/噩梦）+回避（不敢坐车/回避谈话）+警觉增高（易激惹/警惕）+持续>1月→PTSD。

197. [batch007_M10_A2_002] 患者，男，20岁，大一新生。入学1月后适应困难，孤独、经常哭泣、不愿参加集体活动、成绩下降。与离开家乡进入新环境密切相关。最可能诊断：

- A. 重度抑郁发作
- B. 适应障碍伴抑郁心境 ☒
- C. 社交焦虑障碍
- D. 分离焦虑障碍
- E. 回避性人格障碍

答案：B | 应用 | P139

解析：明确应激源（入学/离家）+应激后1-3月起病+情绪行为症状+未达到抑郁发作诊断标准，符合适应障碍。

198. [batch007_M10_A2_003] 急性应激障碍与PTSD的时间鉴别点是：

- A. 急性症状≤1月，PTSD症状>1月 ☒
- B. 急性症状≤1周，PTSD症状>1周
- C. 急性症状≤3天，PTSD症状>3天
- D. 急性症状≤3月，PTSD症状>3月
- E. 二者时间标准基本一致

答案：A | 应用 | P136

解析：核心鉴别点：急性应激障碍3天-1月；PTSD>1月。超过1月即修正为PTSD诊断。

病例

患者，女，28岁。7月前遭遇严重交通事故（目睹同伴当场死亡）。近5月反复出现车祸场景闪回和噩梦，不敢坐车，回避与车祸相关谈话，易激惹、对周围高度警惕、惊跳反应增强。近2月出现情绪低落、兴趣减退、入睡困难。

199. [batch007_v3_EXT_A3_005_Q1] 该患者最可能的诊断是：

- A. 急性应激障碍ASD
- B. 创伤后应激障碍PTSD伴抑郁 ☒
- C. 广泛性焦虑障碍
- D. 适应障碍伴抑郁心境
- E. 惊恐障碍伴广场恐惧

答案：B | 应用

解析：严重创伤事件（目睹死亡）+闯入性症状（闪回/噩梦）+回避（不敢坐车/回避谈话）+警觉增高（易激惹/警惕/惊跳）+认知情绪负性改变（情绪低落/兴趣减退）+持续>1月→PTSD伴抑郁。A需<1月；D应激强度不足。

200. [batch007_v3_EXT_A3_005_Q2] 该患者首选的循证心理治疗方法是：

- A. 精神分析长程治疗
- B. 创伤聚焦CBT或EMDR ☒
- C. 单纯放松训练

- D. 催眠回溯治疗
- E. 系统性家庭治疗

答案：B | 应用

解析：PTSD循证心理治疗首选：创伤聚焦CBT（延长暴露疗法/认知加工疗法）和EMDR（眼动脱敏与再加工）。2023年APA强烈推荐级别。A/C/D/E证据级别较低或非PTSD一线治疗。

201. [batch007_v3_EXT_A3_005_Q3] 若患者共病抑郁需联合药物治疗，优先选择的药物是：

- A. 舍曲林或帕罗西汀SSRI类 ☒
- B. 碳酸锂心境稳定剂
- C. 奥氮平抗精神病药
- D. 苯二氮草类长期维持
- E. 哌甲酯中枢兴奋剂

答案：A | 应用

解析：PTSD药物治疗首选SSRI：舍曲林和帕罗西汀为FDA批准用于PTSD。可改善PTSD三大核心症状群及共病抑郁。B用于双相；C非PTSD一线；D BZD不推荐长期用于PTSD（可能恶化）；E无PTSD适应证。

202. [batch007_v3_EXT_A3_005_Q4] PTSD与急性应激障碍ASD的主要鉴别点是：

- A. ASD有闪回而PTSD没有闪回症状
- B. 症状持续时间以1个月为界，超过考虑PTSD ☒
- C. ASD发生于成人而PTSD仅见于儿童
- D. ASD需要药物治疗而PTSD仅需心理治疗
- E. 二者在临床表现上完全不同无法比较

答案：B | 应用

解析：核心鉴别点：时间窗。ASD=创伤后3天至1月；PTSD=症状持续>1月。两者临床表现高度重叠（闯入+回避+高警觉+负性改变），区别主要在于持续时间。超过1月原ASD诊断应修正为PTSD。

共用选项

- A. 急性应激障碍
- B. PTSD

- C. 适应障碍
- D. 广泛性焦虑障碍
- E. 惊恐障碍

203. [batch007_B1_09_Q1] 创伤后立即发病，持续3天至1个月

答案：A | 理解 | P134-P143, P162-P175

解析：标准答案：A

204. [batch007_B1_09_Q2] 应激源后1-3月起病，应激源消除后6个月内缓解

答案：C | 理解 | P134-P143, P162-P175

解析：标准答案：C

X型题

205. [batch007_M10_X_001] PTSD警觉性增高症状包括：

- A. 易激惹行为和攻击行为
- B. 过度警觉，高度警惕周围环境
- C. 惊跳反应增强
- D. 注意力集中困难和睡眠障碍
- E. 冒险或自我毁灭行为

答案：ABCD | 记忆 | P136

解析：PTSD警觉增高症状群：易激惹/攻击、过度警觉、惊跳反应增强、注意力困难、睡眠障碍、冒险行为。以上全属警觉增高症状。

206. [batch007_M10_X_002] PTSD认知和情绪负性改变包括：

- A. 创伤事件某些重要方面遗忘
- B. 持续负性信念和歪曲归因如自责
- C. 持续负性情绪如恐惧愤怒内疚
- D. 显著兴趣减退和不愿参与活动
- E. 与他人的疏远感和社会隔离

答案：ABCD | 记忆 | P136

解析：PTSD认知情绪负性改变：遗忘、负性信念/歪曲归因、持续负性情绪、兴趣减退、疏远感/社会隔离。以上全属该症状群。

207. [batch007_M10_X_003] PTSD患病的易感因素包括：

- A. 既往存在焦虑或抑郁障碍病史
- B. 女性性别是重要风险因素
- C. 既往创伤史增加PTSD发生风险
- D. 低智商和神经质人格特征
- E. 缺乏社会支持

答案：ABCD | 记忆 | P134-P136

解析：PTSD易感因素：焦虑/抑郁史+女性+既往创伤史+低智商+神经质+缺乏社会支持。高智商和社会支持良好为保护因素。

208. [batch007_M10_X_004] PTSD回避症状的具体表现包括：

- A. 回避与创伤事件相关的刺激情景和人物
- B. 回避与创伤相关的记忆思考或感受
- C. 回避可能唤起创伤回忆的外部线索
- D. 闪回和反复出现的创伤性噩梦
- E. 与创伤事件的某些方面相关的遗忘

答案：ABC | 理解 | P135-P136

解析：回避症状：回避创伤相关的刺激/情景/人物/回忆/思考/感受/外部线索。D闪回噩梦属于闯入性症状；E遗忘属于认知负性改变症状群。三者分属不同症状群。

M11 睡眠障碍

A1型题

209. [batch007_M11_A1_001] 慢性失眠障碍的诊断要求症状频率和持续时间为：

- A. 每周≥1次，持续≥1月
- B. 每周≥3次，持续≥3月 ☒
- C. 每周≥2次，持续≥6月
- D. 每周≥5次，持续≥1月
- E. 每周≥3次，持续≥1月

答案：B | 记忆 | P249

解析：慢性失眠：入睡困难/维持困难/早醒，频率≥3次/周，持续≥3月，且引起日间功能损害。短期失眠<3月无频率要求。

210. [batch007_M11_A1_002] 失眠障碍的首选非药物治疗方法是：

- A. 长期苯二氮䓬类维持
- B. CBT-I ☒
- C. 褪黑素受体激动剂长期
- D. rTMS类药物
- E. 针灸推拿中药

答案：B | 记忆 | P251

解析：CBT-I（失眠认知行为治疗）是慢性失眠的首选治疗，包括睡眠限制、刺激控制、认知疗法、睡眠卫生教育、放松训练。药物仅为短期辅助。

211. [batch007_M11_A1_003] 嗜睡障碍诊断要求日间过度思睡的持续时间和频率为：

- A. 每周≥1次，持续≥1月
- B. 每周≥3次，持续≥3月 ☒
- C. 每日出现，持续≥6月
- D. 每周≥2次，持续≥1月
- E. 每周≥5次，持续≥2周

答案：B | 记忆 | P252

解析：嗜睡障碍：日间过度思睡≥3次/周、持续≥3月，需排除OSA（打鼾+肥胖+呼吸暂停）、精神障碍、躯体疾病等。

212. [batch007_M11_A1_004] DSWPD睡眠-觉醒节律障碍指的是：

- A. 提前型，入睡和觉醒时间均提前
- B. 延迟型，入睡和觉醒时间均延迟 ☒
- C. 不规则型，睡眠片段化分布全天
- D. 轮班工作型障碍
- E. 时差反应综合征

答案：B | 理解 | P258

解析：DSWPD（Delayed Sleep-Wake Phase Disorder）=延迟型：入睡和觉醒时间均延迟（"夜猫子"模式）。ASWPD=提前型（早睡早醒）。

213. [batch007_M11_A1_005] 短期失眠与慢性失眠的鉴别要点是：

- A. 短期失眠<3月无频率要求，慢性失眠≥3月且≥3次/周 ☒

- B. 短期失眠<1月，慢性失眠≥1月
- C. 两者症状频率和持续时间标准基本一致
- D. 短期失眠仅入睡困难，慢性失眠仅早醒
- E. 短期失眠不需任何治疗，慢性失眠必须药物治疗

答案：A | 记忆 | P249-P251

解析：短期失眠<3月无频率要求；慢性失眠≥3月且≥3次/周+日间功能损害。B错误（1月非标准区分）。E错误（短期失眠也需CBT-I干预）。

A2型题

214. [batch007_M11_A2_001] 患者，男，45岁，近4月入睡困难（躺下1-2小时入睡），睡眠浅易醒，每周约4-5晚受影响。白天疲劳嗜睡、注意力不集中。最合适初始处理：

- A. 长期苯二氮䓬类快速改善睡眠
- B. CBT-I作为一线治疗 ☒
- C. 褪黑素作为唯一长期维持
- D. 电抽搐治疗根治失眠
- E. 多导睡眠监测排除所有疾病

答案：B | 应用 | P251

解析：慢性失眠（≥3次/周、≥3月），CBT-I为首选一线治疗。药物仅短期辅助。表现为典型入睡困难和维持困难。

215. [batch007_M11_A2_002] 患者，男，50岁，肥胖（BMI 32），家属诉其夜间打鼾响亮且有呼吸暂停。白天过度嗜睡，开会开车都容易打瞌睡。最需要进行的检查是：

- A. 头颅MRI扫描
- B. 多导睡眠监测PSG ☒
- C. 脑电图检查
- D. 甲状腺功能检测
- E. MMSE认知评估

答案：B | 应用 | P252

解析：肥胖+打鼾+呼吸暂停+日间嗜睡→高度怀疑阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA），PSG为诊断金标准。A排除颅内病变；C排除癫痫；D排除甲减所致嗜睡。

共用选项

- A. 慢性失眠障碍
- B. 嗜睡障碍
- C. 发作性睡病
- D. 阻塞性睡眠呼吸暂停
- E. 延迟型睡眠-觉醒节律障碍

216. [batch007_B1_10_Q1] 入睡困难、维持困难或早醒 ≥ 3 次/周，持续 ≥ 3 月，引起日间功能损害

答案：A | 记忆 | P249-P261

解析：标准答案：A

217. [batch007_B1_10_Q2] 日间过度思睡 ≥ 3 次/周，持续 ≥ 3 月，伴打鼾、肥胖、夜间呼吸暂停

答案：D | 记忆 | P249-P261

解析：标准答案：D

X型题

218. [batch007_M11_X_001] 失眠障碍鉴别诊断需排除的情况包括：

- A. 其他睡眠障碍如OSA和不宁腿综合征
- B. 精神障碍相关性失眠如抑郁焦虑继发
- C. 躯体疾病相关失眠如慢性疼痛心衰
- D. 物质或药物所致失眠如咖啡因酒精戒断
- E. 故意减少睡眠时间的睡眠剥夺

答案：ABCD | 分析 | P249

解析：失眠鉴别需排除：其他睡眠障碍（OSA/RLS）、精神障碍（抑郁/焦虑）、躯体疾病（疼痛/心衰/COPD）、物质/药物、故意睡眠剥夺。以上全部需排除。

M12 躯体治疗

A1型题

219. [batch007_M12_A1_001] 精神药物按治疗用途可分为五大类：

- A. 抗精神病药、抗抑郁药、心境稳定剂、抗焦虑药、精神激活药 ☒
- B. 抗精神病药、抗抑郁药、抗癫痫药、镇静催眠药、中枢兴奋剂

- C. 抗精神病药、抗焦虑药、镇静催眠药、抗癫痫药、抗抑郁药
- D. 心境稳定剂、抗抑郁药、抗焦虑药、镇静催眠药、抗精神病药
- E. 抗抑郁药、抗精神病药、镇静催眠药、中枢兴奋剂、抗癫痫药

答案：A | 理解 | P290

解析：精神药物五大类：①抗精神病药②抗抑郁药③心境稳定剂（抗躁狂药）④抗焦虑药⑤精神激活药（中枢兴奋剂）。基于治疗用途分类。

220. [batch007_M12_A1_002] 第一代抗精神病药的主要作用机制是：

- A. 阻断5-HT_{2A}受体，改善阴性认知症状
- B. 主要阻断D₂受体，有效控制阳性症状 ☒
- C. 激动GABA-A受体，增强抑制性传导
- D. 阻断NMDA受体，减少谷氨酸兴奋毒性
- E. 激动5-HT_{1A}受体，产生抗焦虑抗抑郁效应

答案：B | 理解 | P291

解析：一代（典型）抗精神病药主要通过阻断D₂受体发挥抗精神病作用（控制阳性症状），但EPS明显。代表药：氯丙嗪、氟哌啶醇、舒必利。

221. [batch007_M12_A1_003] 阻断M₁胆碱受体主要导致：

- A. EPS和高催乳素血症
- B. 口干、便秘、排尿困难、视物模糊、记忆障碍 ☒
- C. 直立性低血压和反射性心动过速
- D. 镇静嗜睡和体重增加
- E. QTc间期延长和尖端扭转风险

答案：B | 理解 | P292

解析：受体-副作用：D₂→EPS+高催乳素；M₁→抗胆碱副作用（口干/便秘/排尿困难/视物模糊/记忆障碍）；α₁→低血压/心动过速；H₁→镇静/体重↑。

222. [batch007_M12_A1_004] 第二代抗精神病药在受体水平的特征性机制是：

- A. 高选择性高亲和力D₂完全阻断
- B. 5-HT_{2A}与D₂双重阻断，5-HT_{2A}/D₂比例较高 ☒
- C. 主要激动5-HT_{1A}，对D₂几乎无亲和力
- D. 选择性阻断NMDA受体，降低谷氨酸传导
- E. 非选择性阻断所有单胺类神经递质受体

答案：B | 理解 | P292

解析：二代（非典型）特征为5-HT_{2A}+D₂双重阻断，5-HT_{2A}/D₂阻断比例较高。这使EPS减少且对阴性/认知症状有一定改善。

223. [batch007_M12_A1_005] 恶性综合征（NMS）典型表现不包括：

- A. 高热，体温常>38°C
- B. 肌强直，全身肌肉高度僵硬
- C. CPK显著升高
- D. 皮疹伴嗜酸性粒细胞增多和肝功能损害 ✓
- E. 意识障碍和自主神经不稳定

答案：D | 理解 | P293

解析：NMS特征：高热+肌强直+CPK↑+意识障碍+自主神经不稳。D为药物过敏反应表现，非NMS特征。

224. [batch007_M12_A1_006] 氯氮平使用中最重要安全性监测是：

- A. 每月监测肝功能的表现
- B. 前18周每周监测血常规，早期发现粒细胞缺乏 ✓
- C. 每季度监测甲功的表现
- D. 每月监测肾功能的表现
- E. 每年监测骨密度的表现

答案：B | 记忆 | P293

解析：氯氮平最严重风险为粒细胞缺乏（1-2%），前18周每周监测血常规（WBC+ANC），此后每2周至1年，之后每4周。

225. [batch007_M12_A1_007] SSRI常见副作用不包括：

- A. 胃肠道反应如恶心呕吐腹泻
- B. 性功能障碍如性欲下降勃起障碍射精延迟
- C. 激活焦虑尤其在治疗初期
- D. 粒细胞缺乏和严重感染 ✓
- E. 5-HT综合征风险尤其与MAOI联用时

答案：D | 记忆 | P298

解析：SSRI常见副作用：胃肠道反应、性功能障碍、激活焦虑、5-HT综合征风险。D粒细胞缺乏是氯氮平特有风险，非SSRI副作用。

226. [batch007_M12_A1_008] 苯二氮草类的主要药理作用机制是：

- A. 阻断D2受体发挥抗精神病抗躁狂作用
- B. 增强GABA-A受体功能，产生抗焦虑镇静肌松抗惊厥 ☒
- C. 抑制5-HT再摄取发挥抗抑郁抗焦虑作用
- D. 阻断钠离子通道产生心境稳定效应
- E. 激动多巴胺受体产生激活振奋作用

答案：B | 记忆 | P303

解析：苯二氮草类通过增强GABA-A受体功能（正性变构调节）产生：抗焦虑、镇静催眠、肌肉松弛、抗惊厥作用。长期使用有依赖风险。

227. [batch007_M12_A1_009] MECT适应证不包括：

- A. 严重抑郁伴强烈自杀观念自杀行为
- B. 木僵状态和拒食拒水危及生命
- C. 轻度广泛性焦虑障碍作为一线首选 ☒
- D. 药物治疗无效或不能耐受药物副作用
- E. 精神分裂症紧张型木僵与兴奋交替

答案：C | 理解 | P304

解析：MECT适应证：严重抑郁自杀/拒食/木僵、药物无效或不耐受、分裂症紧张型。C轻度焦虑非MECT适应证。

228. [batch007_M12_A1_010] rTMS的特点包括：

- A. 需要全麻和肌肉松弛状态下进行
- B. 无创不需麻醉，对抑郁有肯定治疗效果 ☒
- C. 疗效优于MECT且适用于所有精神障碍
- D. 主要不良反应为认知损害和长期记忆障碍
- E. 必须每周血药浓度监测确保安全性

答案：B | 理解 | P305

解析：rTMS特点：无创、不需麻醉、对抑郁有效（左侧DLPFC高频刺激），副作用少（刺激局部不适/头痛）。

229. [batch007_M12_A1_011] 以下属于第一代抗精神病药的药物组合是：

- A. 利培酮、奥氮平、喹硫平
- B. 氯丙嗪、奋乃静、氟哌啶醇、舒必利 ☒
- C. 阿立哌唑、齐拉西酮、帕利哌酮
- D. 氯氮平、文拉法辛、米氮平
- E. 碳酸锂、丙戊酸钠、拉莫三嗪

答案：B | 记忆 | P291-P292

解析：B为一代典型抗精神病药（D2阻断为主）。A/C为二代非典型抗精神病药；D中氯氮平为二代AP，文拉法辛/米氮平为抗抑郁药；E为心境稳定剂。

230. [batch007_M12_A1_012] 抗精神病药阻断D2受体导致催乳素升高的机制是：

- A. 直接刺激垂体前叶泌乳素细胞分泌
- B. 阻断垂体漏斗部D2受体，解除多巴胺对催乳素的抑制 ☒
- C. 通过5-HT_{2A}受体间接促进催乳素释放
- D. 通过H₁受体介导催乳素合成增加
- E. 通过 α_1 受体促进下丘脑催乳素释放因子

答案：B | 记忆 | P292

解析：D2受体阻断→解除DA对垂体泌乳素细胞的抑制→催乳素升高→溢乳、闭经、性功能↓。利培酮和舒必利催乳素升高最显著。

231. [batch007_M12_A1_013] 抗精神病药常见的药物相互作用不包括以下哪项：

- A. 增加三环类抗抑郁药的血药浓度
- B. 降低癫痫发作阈值诱发癫痫
- C. 加剧抗胆碱能副作用
- D. 显著增强抗生素的抗菌活性 ☒
- E. 逆转肾上腺素的升压作用

答案：D | 记忆 | P296

解析：抗精神病药相互作用：增加TCA血药浓度、降低癫痫阈值、加剧抗胆碱作用、逆转肾上腺素升压。D与抗生素无显著相互作用。

A2型题

232. [batch007_M12_A2_001] 患者，男，28岁，确诊分裂症后服氟哌啶醇第3天，出现双眼上翻、头颈后仰、张口困难。此症状最可能为：

- A. 急性肌张力障碍 ☒
- B. 迟发性运动障碍
- C. 静坐不能
- D. 帕金森综合征
- E. 恶性综合征

答案：A | 应用 | P292

解析：服药第3天（早期）+眼上翻/头后仰/张口困难（局部肌群痉挛）→急性肌张力障碍。多见于年轻男性、氟哌啶醇等高效价药物。抗胆碱药肌注可迅速缓解。

233. [batch007_M12_A2_002] 患者，女，35岁，抑郁服氟西汀20mg/d 2周后自行加用苯乙肼，2天后意识模糊、高热39°C、大汗、肌阵挛、腱反射亢进。最可能诊断：

- A. 恶性综合征（高热、肌强直、CK升高）
- B. 5-HT综合征，由SSRI与MAOI禁忌联用所致 ☒
- C. 恶性高热（高热、肌僵、心动过速、酸中毒）
- D. 抗胆碱能药物所致谵妄（意识模糊、幻觉）
- E. 病毒性脑炎（发热、头痛、脑膜刺激征）

答案：B | 应用 | P299

解析：SSRI（氟西汀）+MAOI（苯乙肼）禁忌联用→5-HT综合征。三联征：意识障碍+自主神经不稳（高热/大汗）+神经肌肉异常（肌阵挛/反射亢进）。氟西汀需5周洗脱期。

234. [batch007_M12_A2_003] 患者，男，45岁，服氯氮平治疗难治性分裂症2月。复查血常规WBC $2.5 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 $0.8 \times 10^9/L$ 。当前最正确处理：

- A. 继续原剂量，加用G-CSF治疗
- B. 立即停用氯氮平，血液科会诊评估处理 ☒
- C. 剂量减半继续服用，三天后复查血常规
- D. 继续原剂量，数值仍在正常范围
- E. 联合碳酸锂改善造血功能提升粒细胞

答案：B | 应用 | P293

解析：ANC $0.8 \times 10^9/L < 1.5 \times 10^9/L$ 已达粒细胞缺乏标准，应立即停用氯氮平、血液科会诊、预防感染、必要时G-CSF。

235. [batch007_M12_A2_004] 患者，男，52岁，双相I型长期服碳酸锂，血锂0.8mmol/L。近日因高血压加用氢氯噻嗪，1周后粗大震颤、恶心呕吐、步态不稳。血锂升至1.8mmol/L。锂中毒最可能原因是：

- A. 锂盐剂量过高需降低每日维持剂量
- B. 噻嗪类利尿剂减少肾脏锂清除致血锂升高 ☒
- C. 患者自行增加了碳酸锂口服剂量
- D. 血锂0.8mmol/L已处于治疗窗上限
- E. 高血压本身导致肾功能急剧下降所致

答案：B | 应用 | P301

解析：噻嗪类利尿剂（氢氯噻嗪）减少肾脏对锂的清除→血锂升高至1.8mmol/L（>1.4中毒阈值）→锂中毒。典型药代动力学相互作用。

236. [batch007_M12_A2_005] 患者，男，45岁，抑郁障碍服帕罗西汀40mg/d 6周。自行突然停药2天后出现头晕、恶心、焦虑、电击样感觉。此症状最可能是：

- A. 5-HT综合征表现
- B. SSRI撤药综合征 ☒
- C. 抑郁症状复燃
- D. 药物过敏反应
- E. 急性肌张力障碍

答案：B | 应用 | P298

解析：帕罗西汀突然停药2天+头晕/恶心/焦虑/电击感→典型的SSRI撤药综合征。帕罗西汀半衰期短（21h），撤药反应最显著。处理：恢复原剂量后缓慢减量（4周以上）。

237. [batch007_M12_A2_006] MECT与rTMS的比较中正确的是：

- A. 两者均需全麻和肌肉松弛条件下进行
- B. MECT需全麻肌松，rTMS无创不需麻醉 ☒
- C. rTMS疗效整体优于MECT
- D. MECT的认知副作用与rTMS基本一致
- E. 两者适应证和禁忌证基本一致

答案：B | 应用 | P304-P305

解析：核心区别：MECT=全麻+肌松+抽搐治疗，适用于严重抑郁自杀/拒食/木僵；rTMS=无创+不需麻醉+对抑郁有效，适用于轻中度抑郁。MECT疗效优于rTMS但认知副作用更多。

X型题

238. [batch007_M12_X_001] 锥体外系反应（EPS）的四型包括：

- A. 急性肌张力障碍
- B. 静坐不能（主观坐立不安、需反复走动）
- C. 药源性帕金森综合征
- D. 迟发性运动障碍
- E. 恶性综合征

答案：ABCD | 记忆 | P292

解析：EPS四型：①急性肌张力障碍②静坐不能③帕金森综合征④迟发性运动障碍（TD）。E恶性综合征虽严重但不归入EPS四型。

239. [batch007_M12_X_002] 抗抑郁药分类匹配正确的有：

- A. 氟西汀、舍曲林→SSRI
- B. 文拉法辛、度洛西汀→SNRI
- C. 米氮平→NaSSA
- D. 安非他酮→NDRI
- E. 阿米替林、多塞平→TCA

答案：ABCD | 记忆 | P298

解析：抗抑郁药分类全匹配：SSRI（氟西汀/舍曲林）、SNRI（文拉法辛/度洛西汀）、NaSSA（米氮平）、NDRI（安非他酮）、TCA（阿米替林/多塞平）。全部正确。

240. [batch007_M12_X_003] MECT（改良电抽搐治疗）的适应证包括：

- A. 严重抑郁伴自杀观念自杀行为需快速起效
- B. 木僵状态和拒食拒水危及生命营养
- C. 药物治疗无效或不能耐受药物副作用
- D. 精神分裂症紧张型木僵与兴奋交替
- E. 双相障碍严重躁狂发作药物治疗欠佳

答案：ABCD | 记忆 | P304

解析：MECT适应证：严重抑郁自杀/拒食/木僵、药物无效/不耐受、分裂症紧张型、严重躁狂药物无效、恶性综合征等。全麻+肌松下安全有效。

241. [batch007_M12_X_004] 抗精神病药受体阻断与副作用的匹配正确的有：

- A. D2受体阻断→EPS和高催乳素血症
- B. M1胆碱受体阻断→口干便秘排尿困难视物模糊记忆障碍
- C. α_1 肾上腺素受体阻断→直立性低血压和心动过速

- D. H1组胺受体阻断→镇静嗜睡和体重增加
- E. 5-HT2A受体阻断→EPS和催乳素升高

答案：ABCD | 理解 | P292

解析：E错误：5-HT2A阻断不直接导致EPS或催乳素升高，相反有助于减少EPS。A/B/C/D均为正确的受体-副作用对应关系。

242. [batch007_M12_X_005] SSRI类药物常见副作用包括以下哪些：

- A. 胃肠道反应如恶心呕吐和腹泻
- B. 性功能障碍如性欲下降和射精延迟
- C. 治疗初期可能出现焦虑激活反应
- D. 5-HT综合征风险尤其与MAOI联用时
- E. 体重显著增加和代谢综合征

答案：ABCD | 理解 | P298-P301

解析：E体重显著增加和代谢综合征主要为米氮平、奥氮平、氯氮平的副作用。SSRI常见：胃肠道反应+性功能障碍+焦虑激活+5-HT综合征风险+撤药综合征。

本批次统计

- 题目总数：242
- A1型：122 | A2型：47 | A3型：20 | B1型：20 | X型：33
- 认知层级：记忆75(31.0%) | 理解90(37.2%) | 应用73(30.2%) | 分析4(1.7%)
- 选项平均长度：11.1字
- 版本：v3 FINAL（Prompt修正版，解决v2过度加长问题）